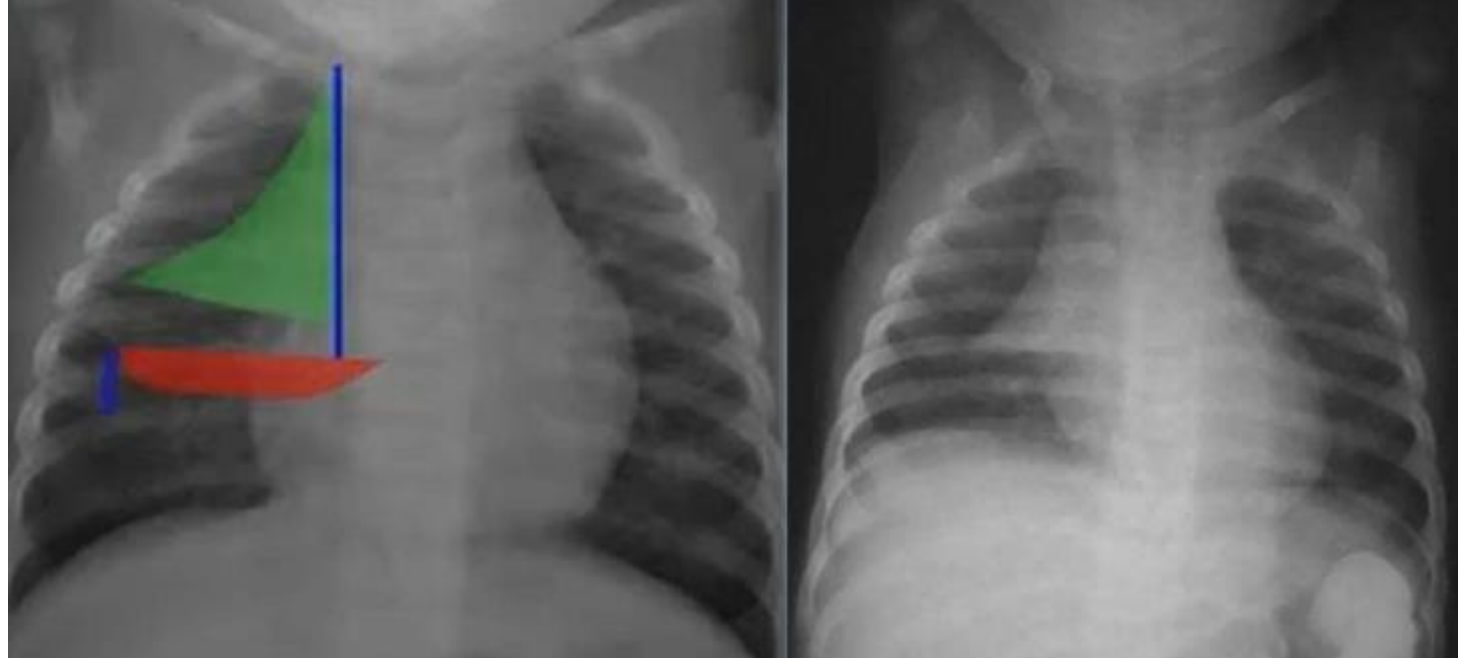
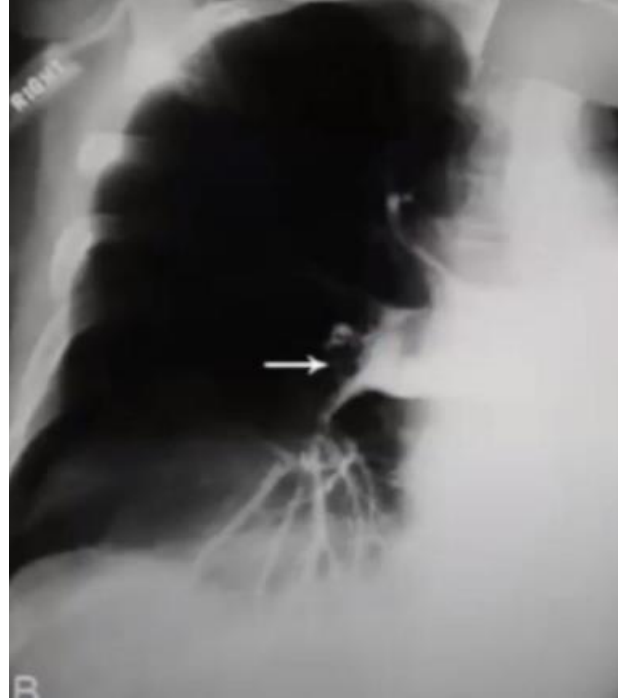


02 Neumologia



Es fisiológico en niños. La involución de la sombra tímica comienza al final del primer año de vida y se completa alrededor de los 3 años.

El **Signo de la Vela** corresponde a una **opacidad triangular** del tejido tímico que se proyecta hacia la derecha o izquierda y a veces en ambas direcciones

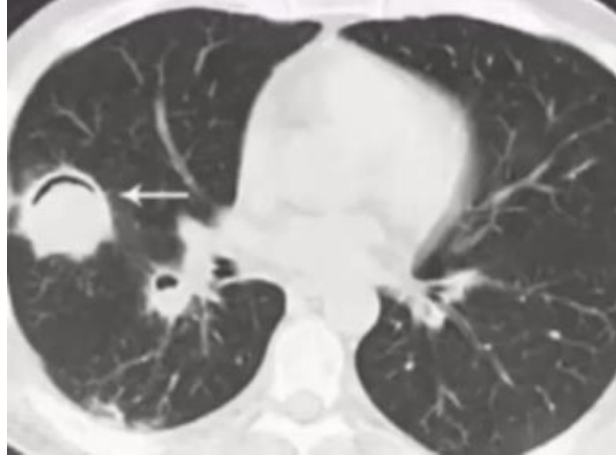


Indicativo para TEP, es
un agrandamiento proximal da arteria
pulmonar.
Tomografia computada sin contraste

Nombre el signo:

Signo de fleischener

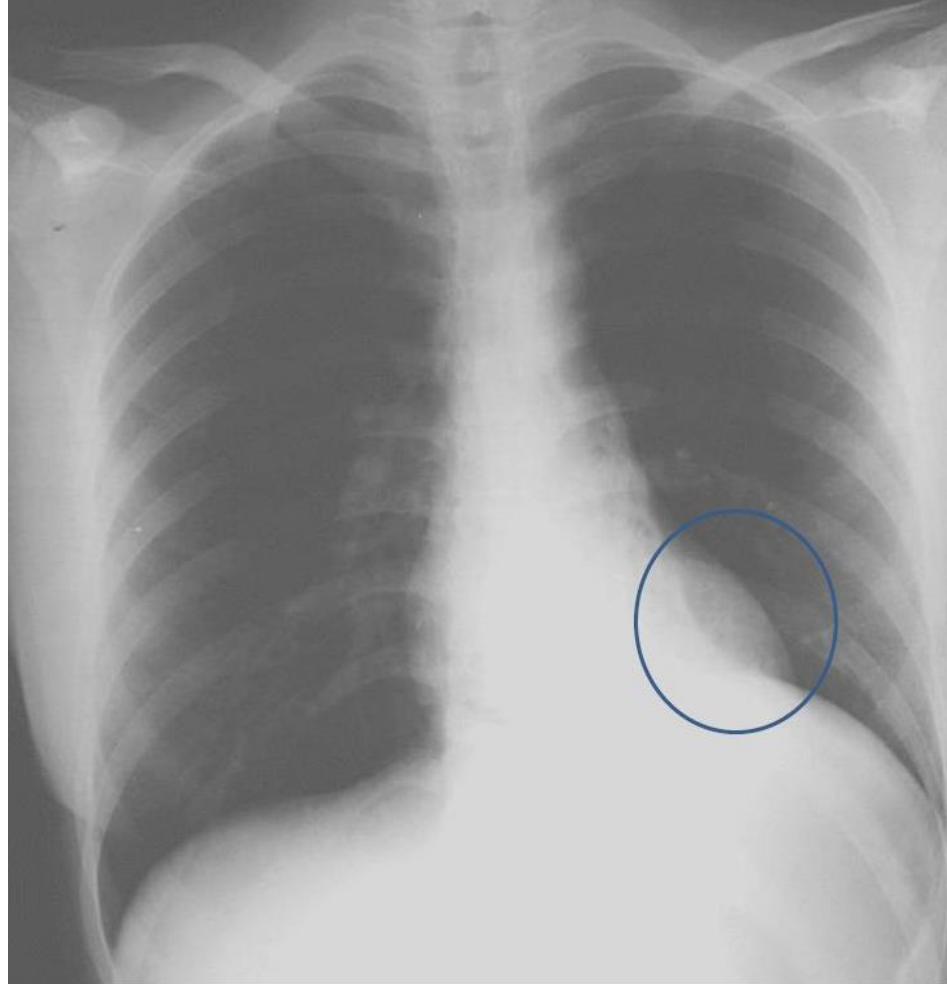
Signo del aire creciente.



Diagnóstico presuntivo:

Absceso pulmonar

TAC ventana pulmonar
sin contraste



Opacidad homogénea que compromete a la lingula, que si es de gran tamaño, termina sobresaliendo del borde cardíaco izquierdo

Diagnóstico presuntivo:

Atelectasia de la lingula

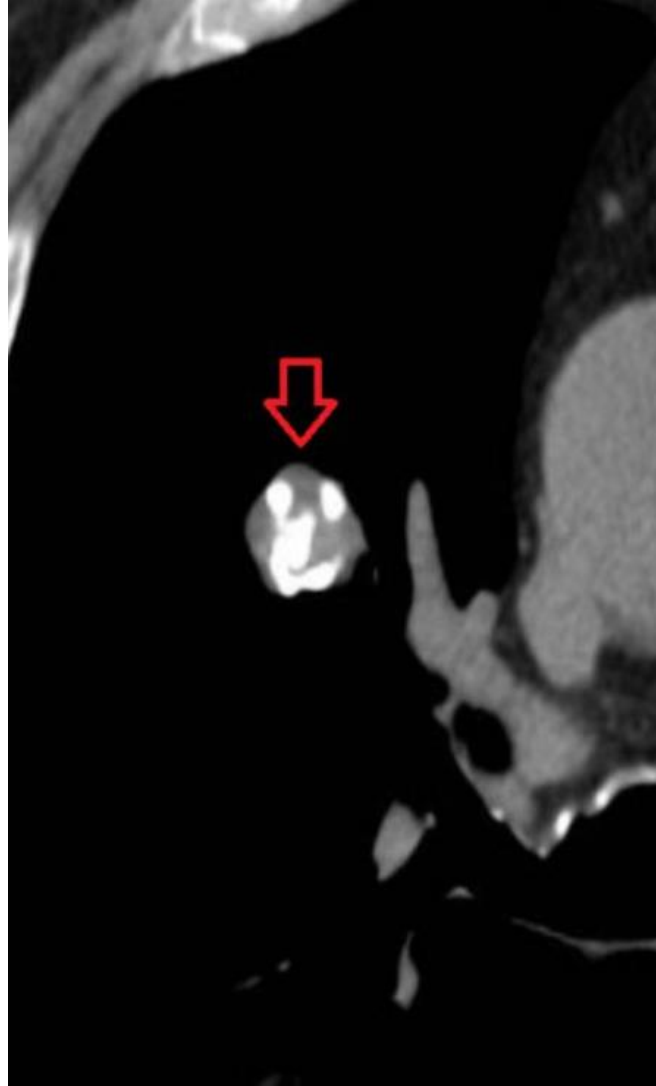
Rx de torax de frente



Nombre el **Signo**:

Atelectasia del lóbulo superior
derecho

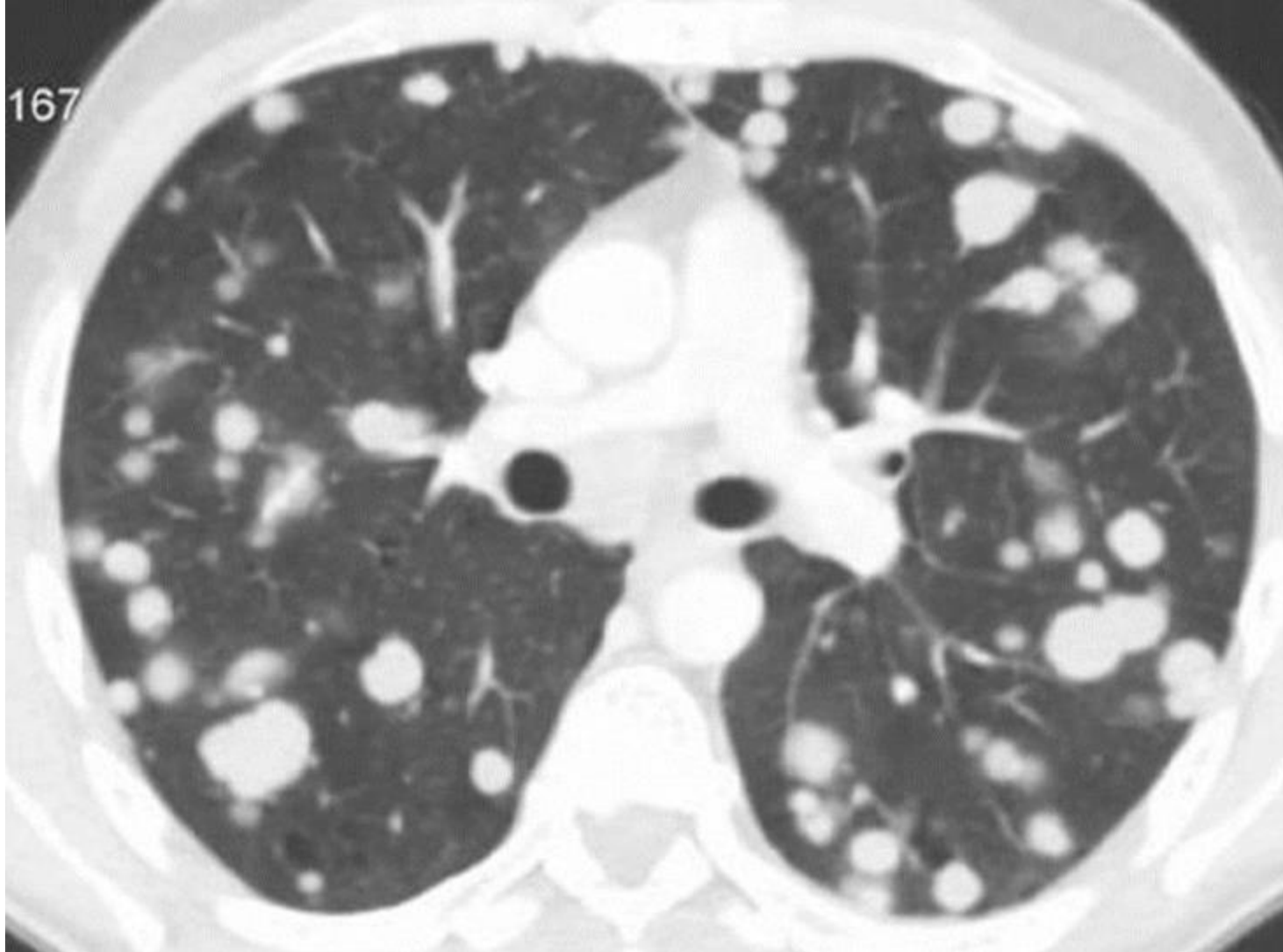
Signo de la S de Golden



TC ventana mediastinica, se observa imagen nodular ubicada en situación parahiliar derecha que presenta area calcicas en su interior (aspect pop corn)

Diagnóstico presuntivo:

Hamartoma pulmonar

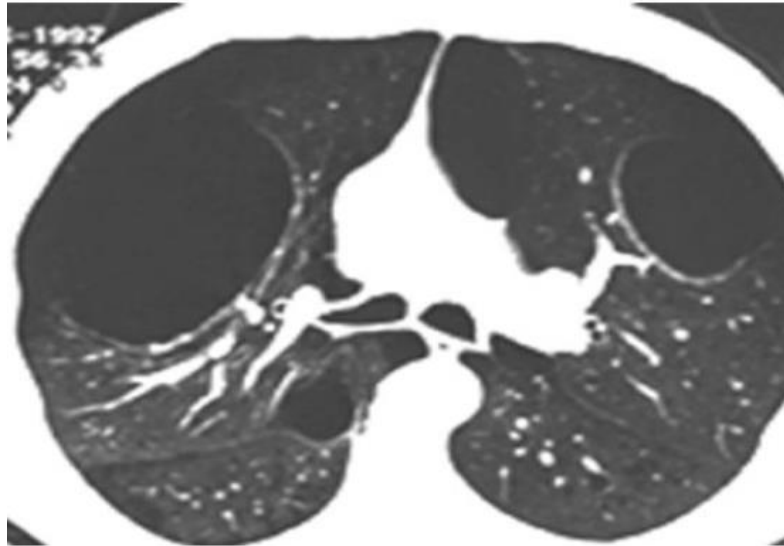


Diagnóstico presuntivo:

Metástasis pulmonar

SUELTA DE GLOBOS.

TAC ventana pulmonar con contraste



Bullas

TAC ventana pulmonar con
contraste

Diagnóstico presuntivo:
Enfisema

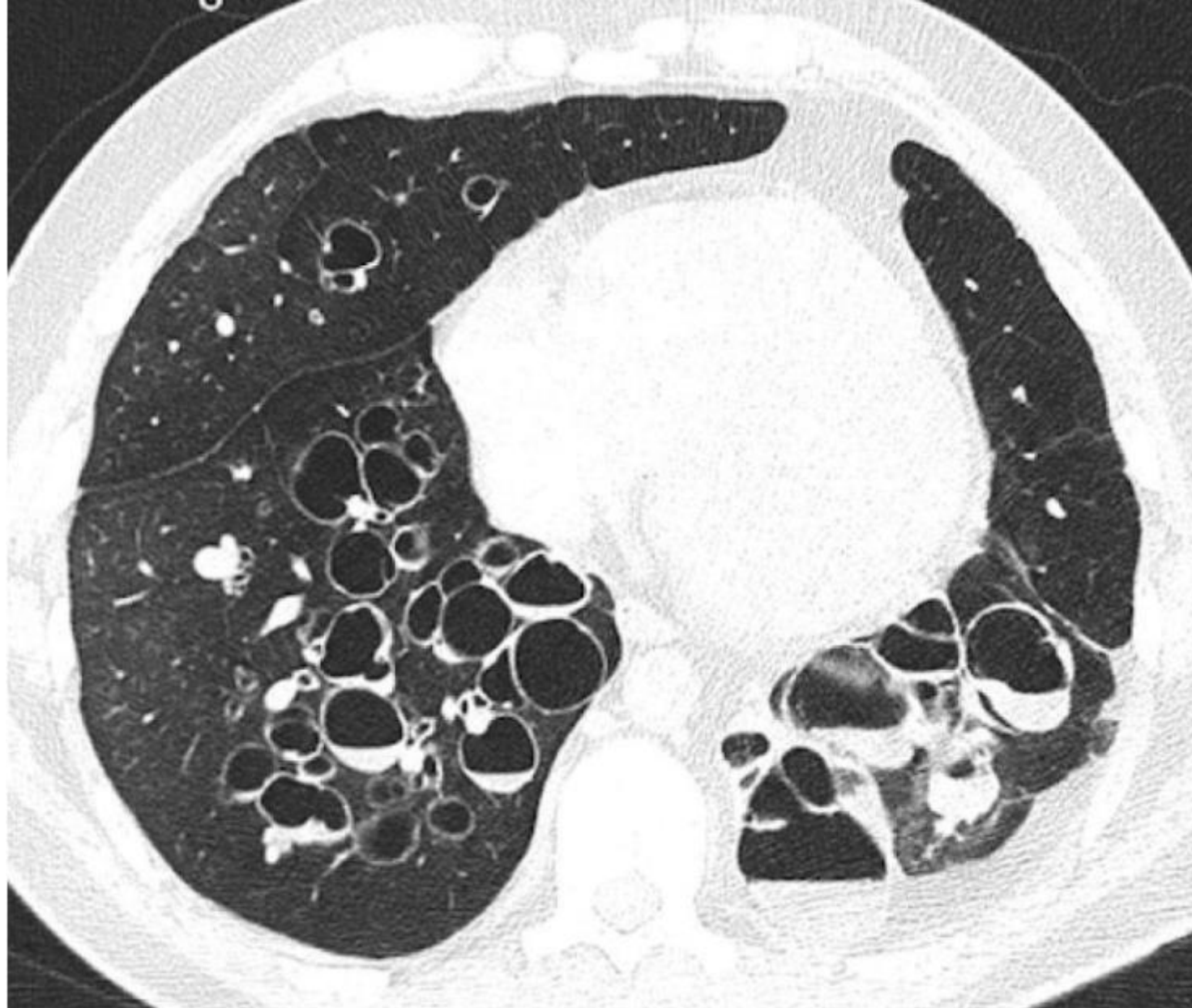
Bullas.



Diagnóstico presuntivo:

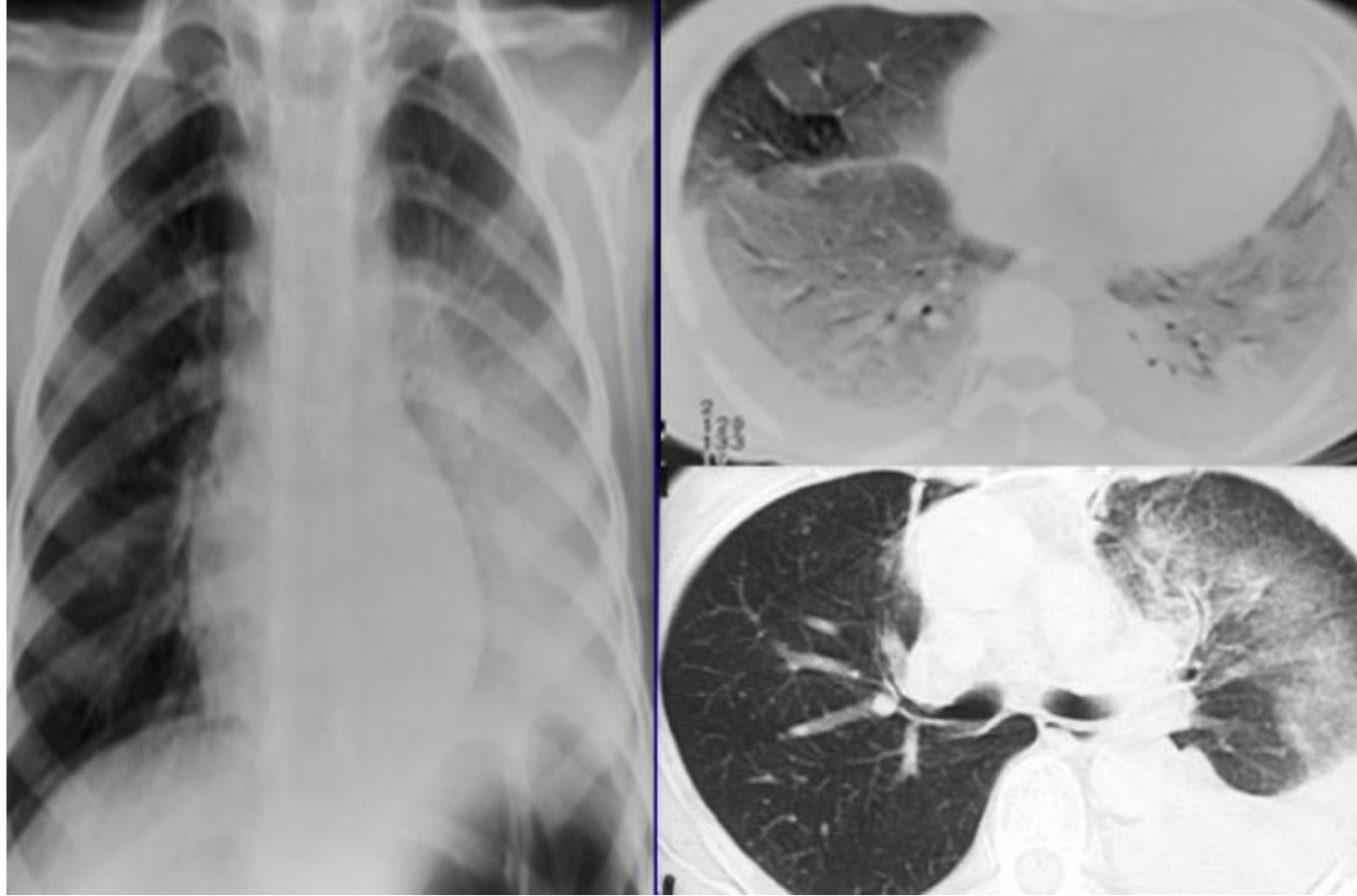
Enfisema

Anillo de Sello.



TAC ventana pulmonar con contraste

Diagnóstico presuntivo:
Bronquiectasias



Se puede ver bien las estructuras vasculares y los bronquios, pero no tengo nitidez.

Cual **Patrón** se puede visualizar en las imágenes abajo?

Dx: Neumonía Atípica

Patrón en vidrio esmerillado

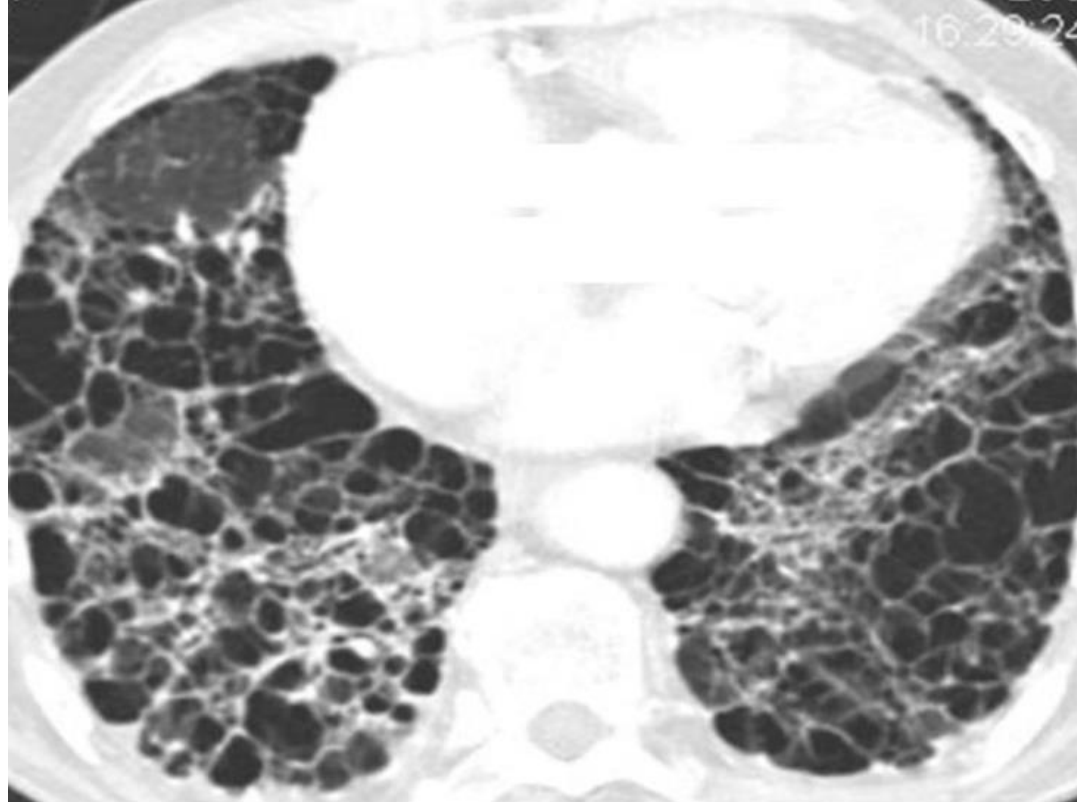


El parénquima con patrón quístico, bilateral.

TAC ventana pulmonar sin contraste

Diagnóstico presuntivo:

Linfangioleiomiomatosis



Sugiere destrucción,
alteración masiva del
intersticio.

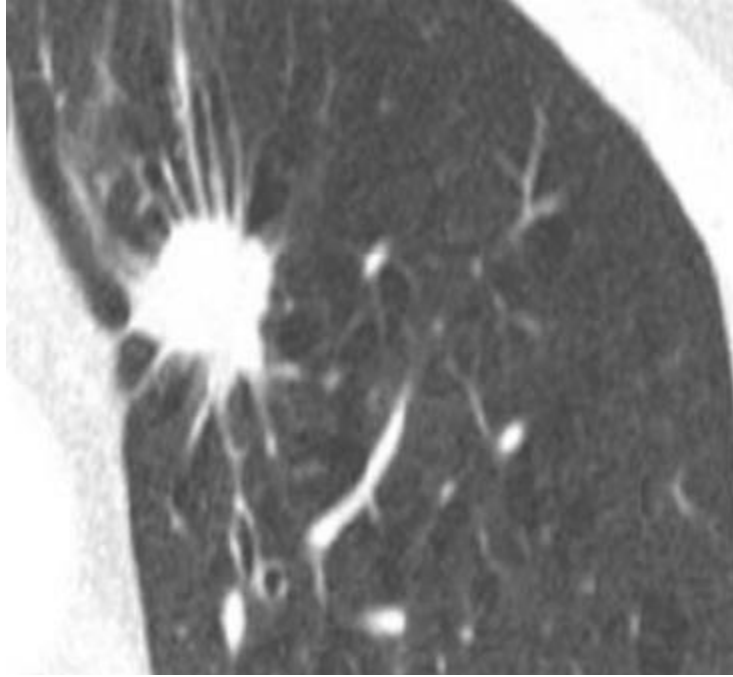
Se ve en pacientes con EPOC
avanzado.

Cual Patrón se visualiza en la TC abajo?

Reticular o pañal de abejas

TAC ventana pulmonar con contraste

Espiculado.



El siguiente patrón tiene mayor probabilidad de ser **benigno o maligno**?

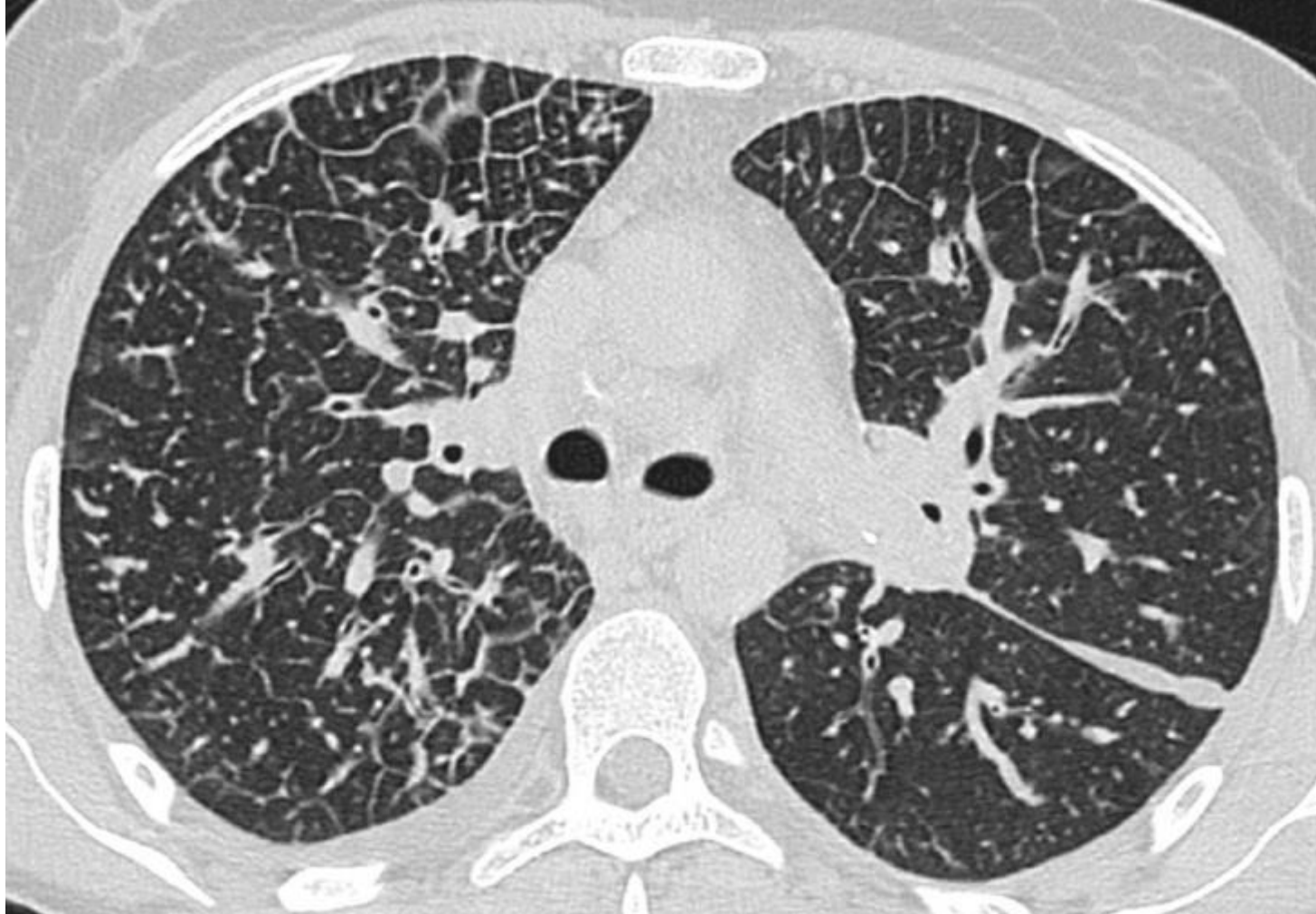
Maligno



Diagnóstico presuntivo:

Rx torax frente

Neumotórax izquierdo

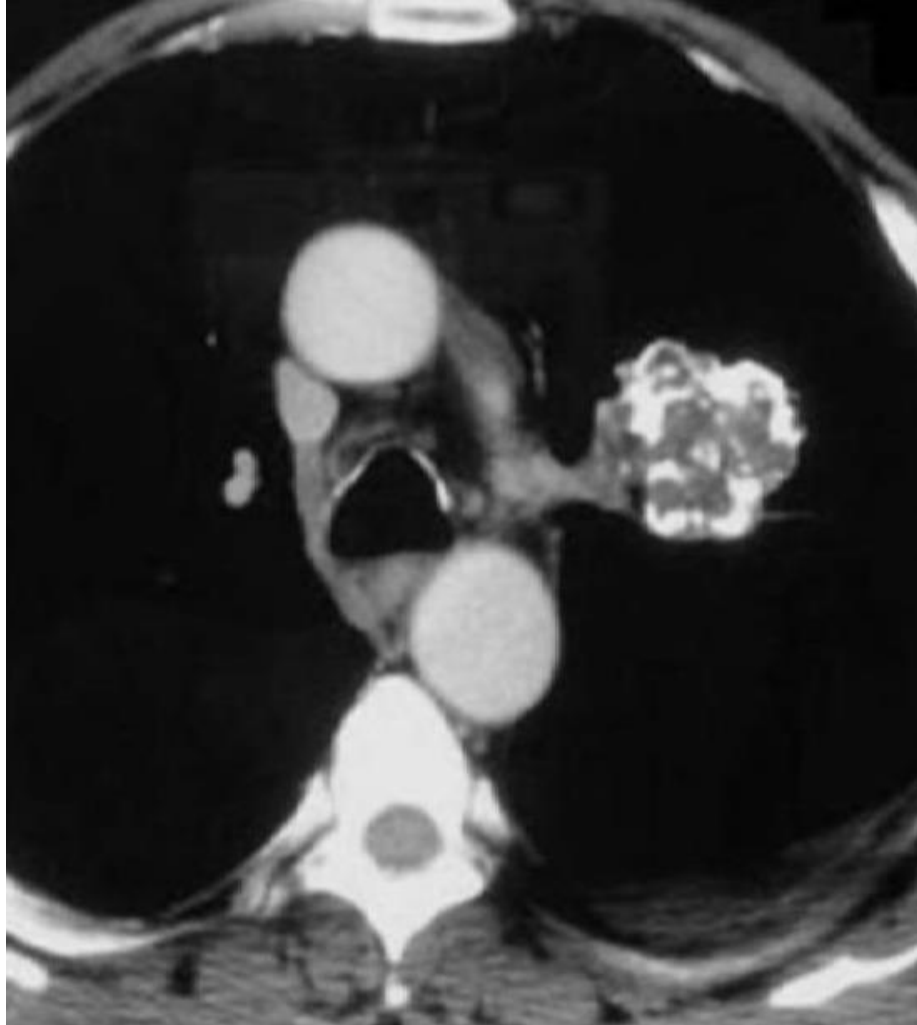


Patrón intersticial lineal:
Engrosamiento intersticial de los septos (tabiques intersticiales engrosados), así que empiezo a ver muchas líneas y eso llama Linfangitis (producto de diseminación de un cáncer, como el cáncer de mama y de tubo digestivo). Lineas B Kerley

Diagnóstico presuntivo:

Linfangitis

TAC ventana pulmonar sin contraste

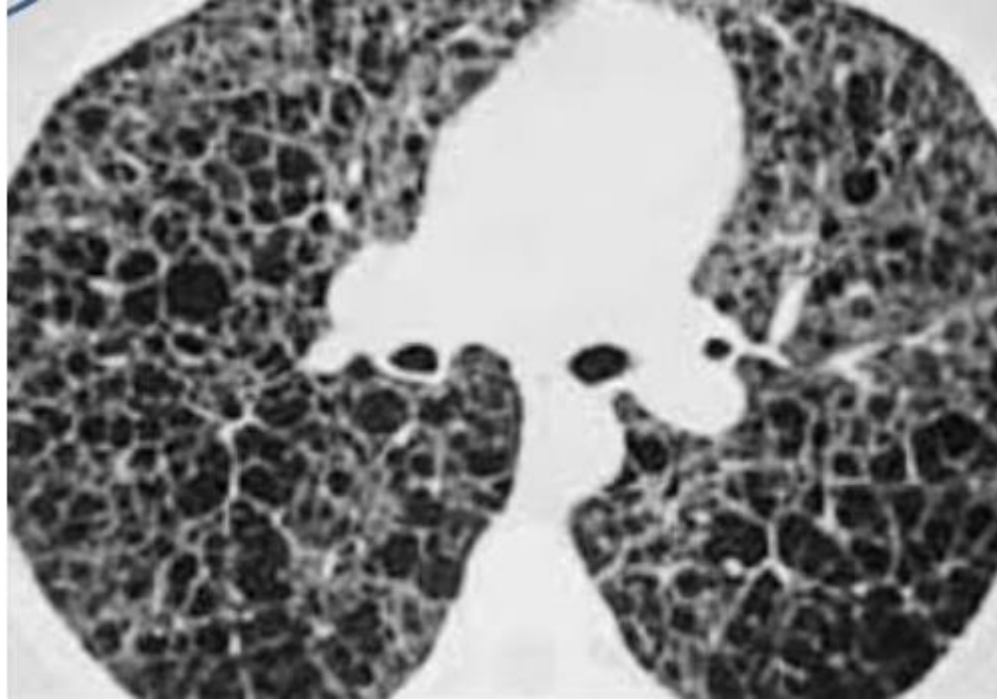


TAC ventana mesdiastinica sin
contraste

Qué tipo de **Patrón tumoral** es?

Patrón maligno

Patrón intersticial reticular.



Diagnóstico presuntivo:

Patrón pañal de abejas (fibrosis)



Patrón nodular producto de la metástasis lo cual llamamos **SUELTA DE GLOBOS**.

Diagnóstico presuntivo:

Metastasis pulmonar



Diagnóstico presuntivo:

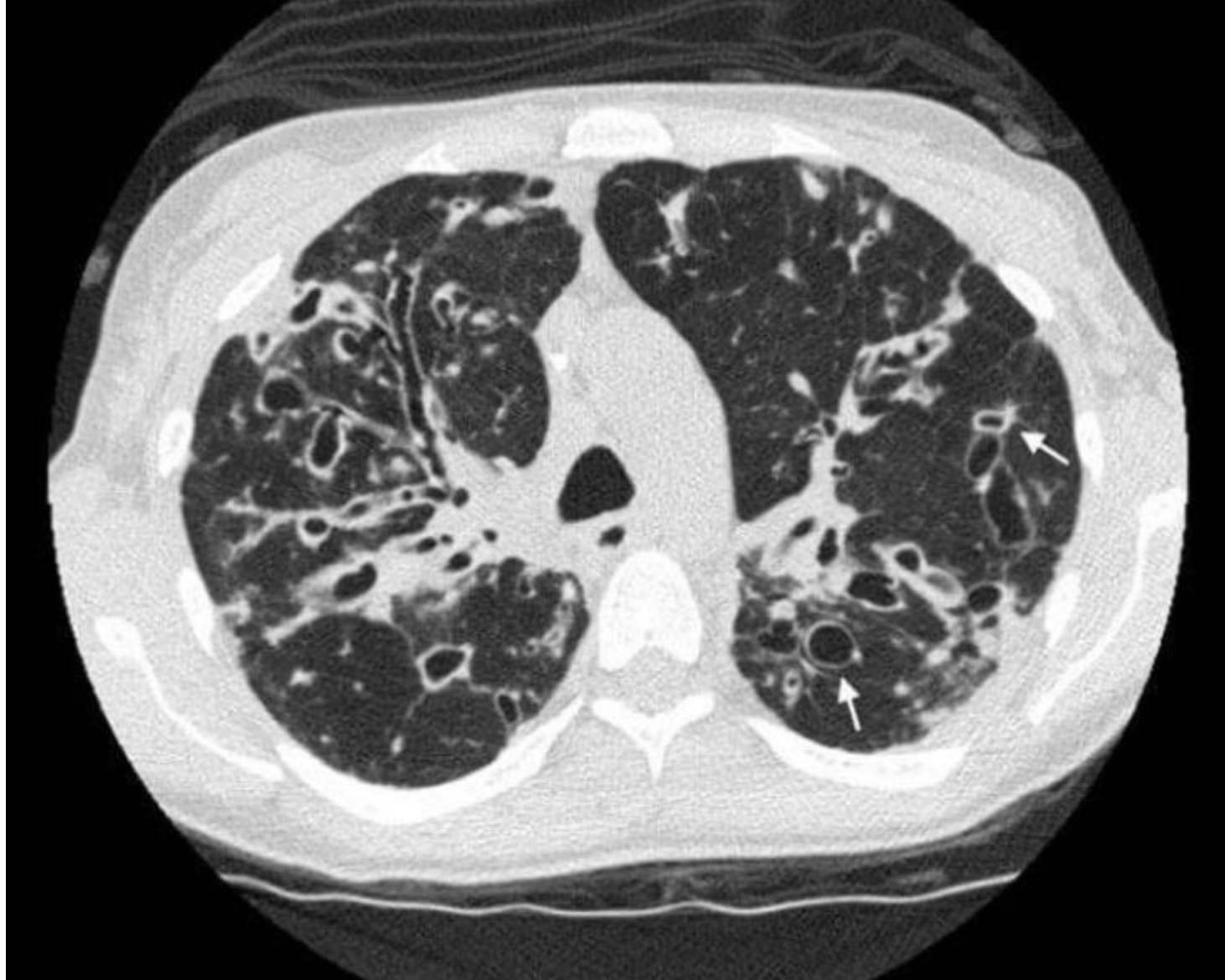
Derrame pleural izquierdo

linea de damoiseau



Diagnóstico presuntivo:

Neumotórax derecho



Diagnóstico presuntivo:

Bronquiectasias

El COVID 19 tiene ese tipo de patrón con estasopacidades en vidrio esmerillado periféricas y subpleurales.



Diagnóstico presuntivo:

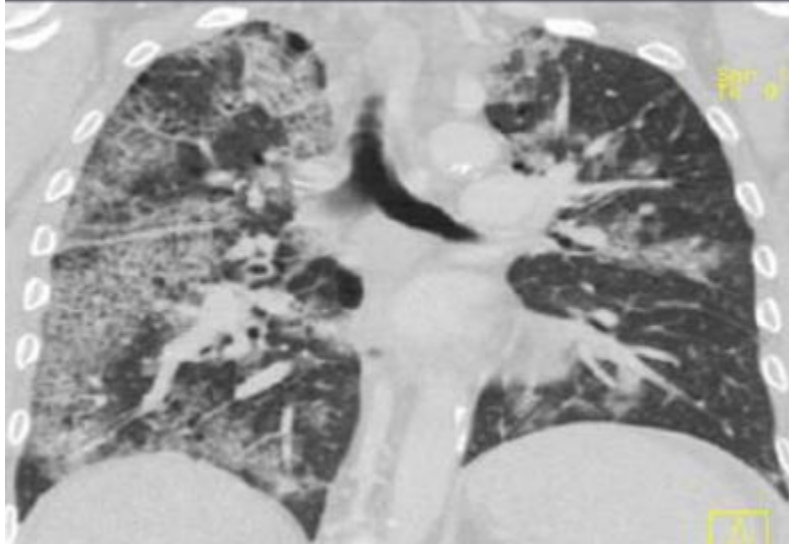
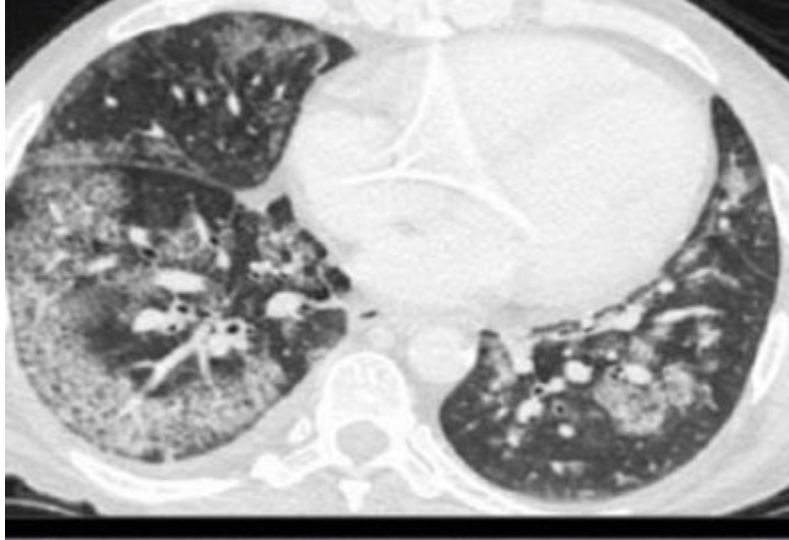
COVID-19

Fibrosis.



Diagnóstico presuntivo:

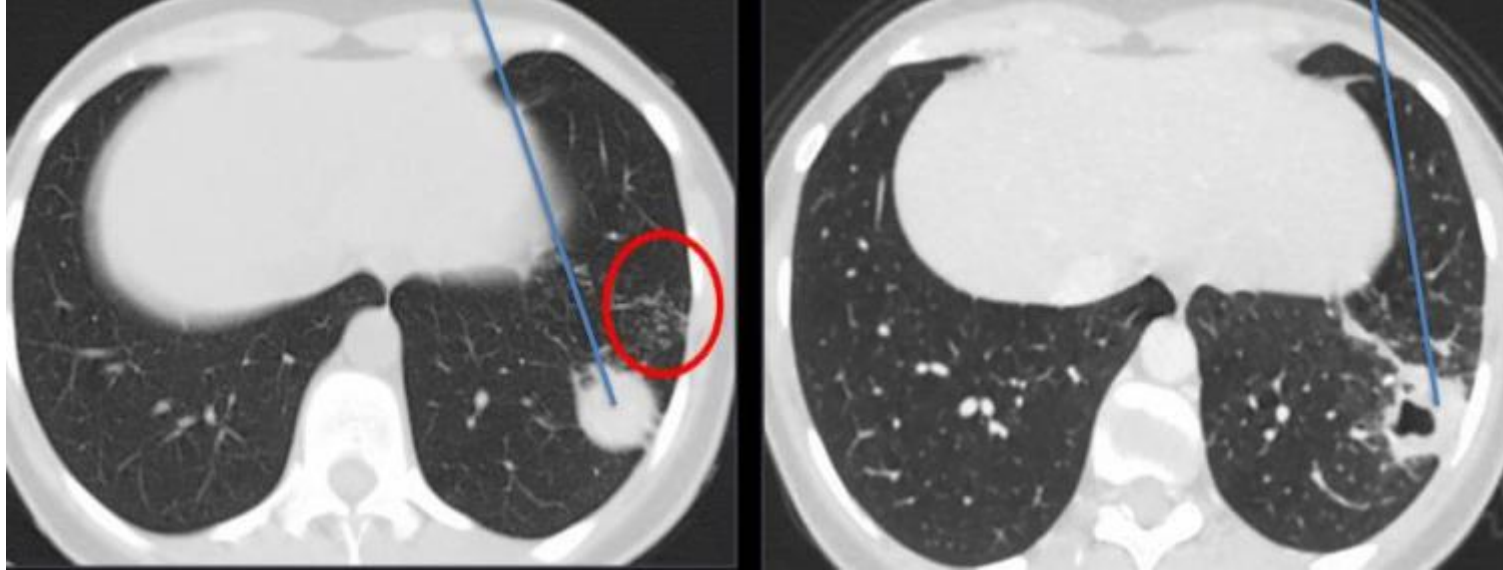
Patrón intersticial reticular



Por *Legionella pneumophila*.
TC una afectación del espacio
aéreo de distribución
parcheada, bilateral y
asimétrica, en forma de
opacidades en vidrio
deslustrado, junto a
engrosamiento del intersticio
interlobulillar, conformando un
patrón en empedrado.

Diagnóstico presuntivo:

Neumonía Atípica

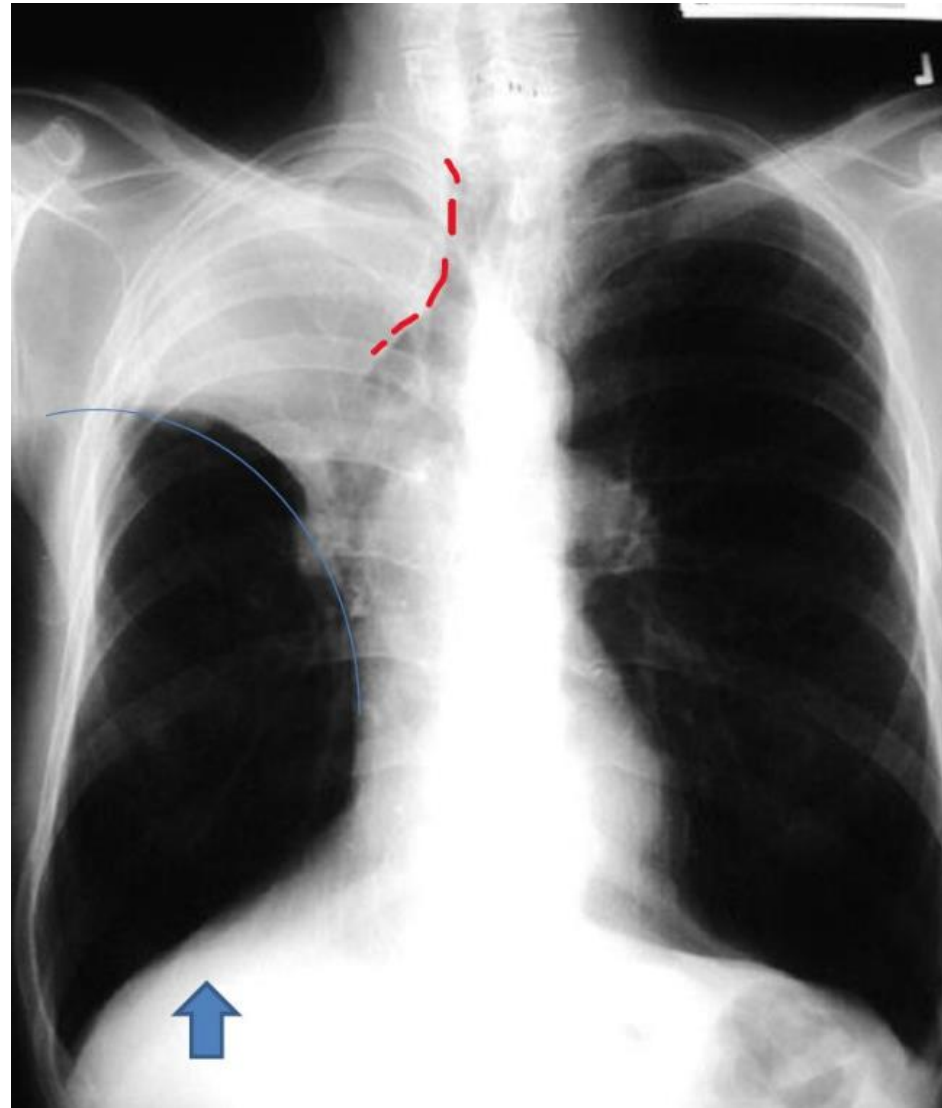


Cortes axiales de TC de tórax
en ventana de
pulmón. Consolidación
cavitada de localización
periférica en el LII con
afectación del parénquima
pulmonar adyacente en forma
de nódulos centrilobulillares y
opacidades en árbol en brote
(círculo rojo).

Diagnóstico presuntivo:

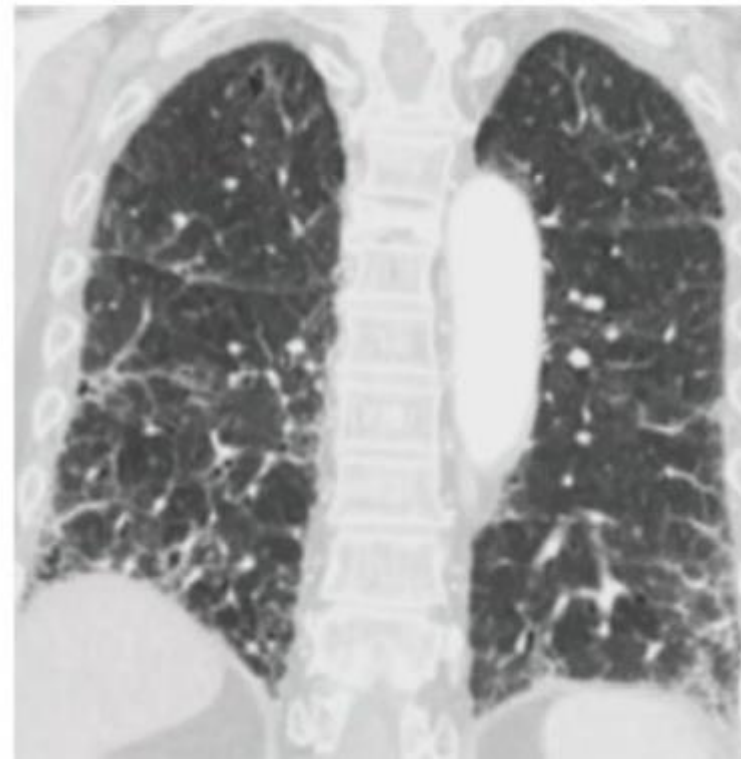
Tuberculosis

Produce una radioopacidad en topografía del lóbulo superior derecho, que adquiere una morfología de S invertida, también llamado Signo de la "S de golden". Elevación del hemidiafragma e hiliohomolateral. Limite bien abrupto a nivel de donde va a terminar la lesión. La cisura esta un poco elevada. Desviación de la tráquea hacia el lado afectado. Aumento de la radiolucidez de los pulmones (insuflación).



Diagnóstico presuntivo:

Atelectasia de lóbulo superior derecho

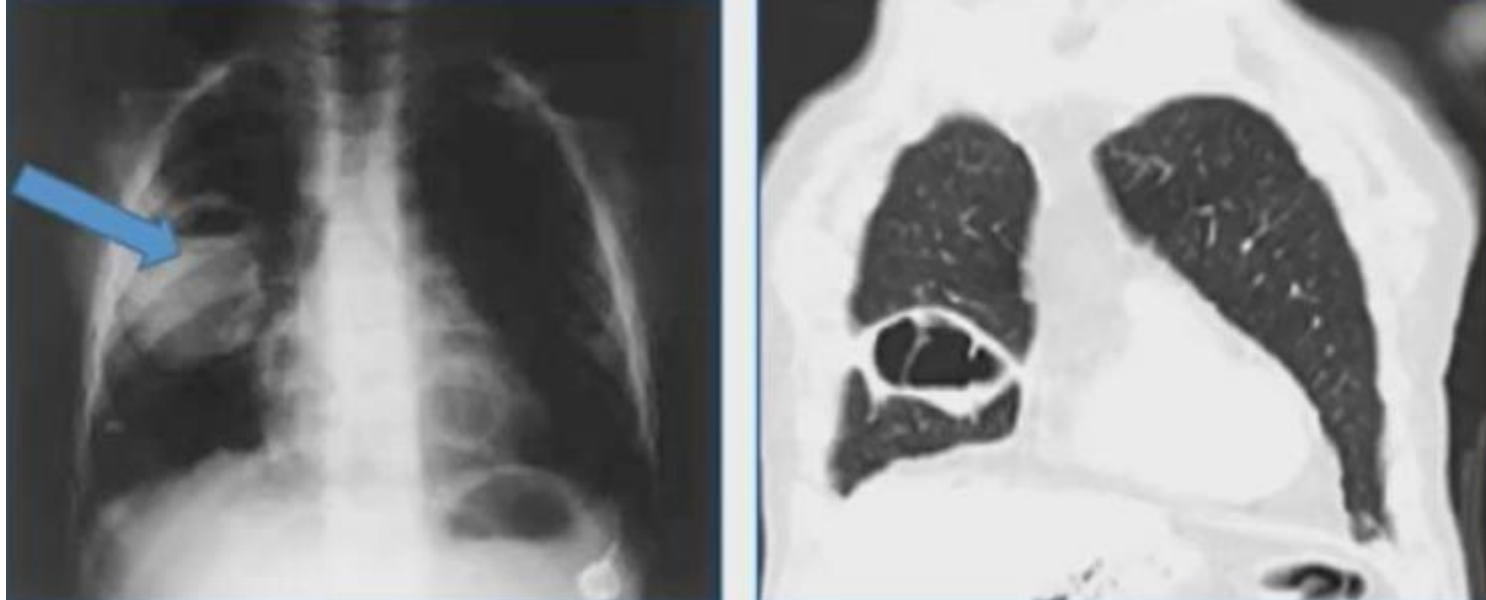


Se observan opacidades lineales que forman redes de encaje con predominio en zonas periféricas del pulmón y leve predilección a lóbulos inferiores.

Causas: Fibrosis pulmonar idiopática, collagenopatías, enfermedades inhalatorias (neumoconiosis).

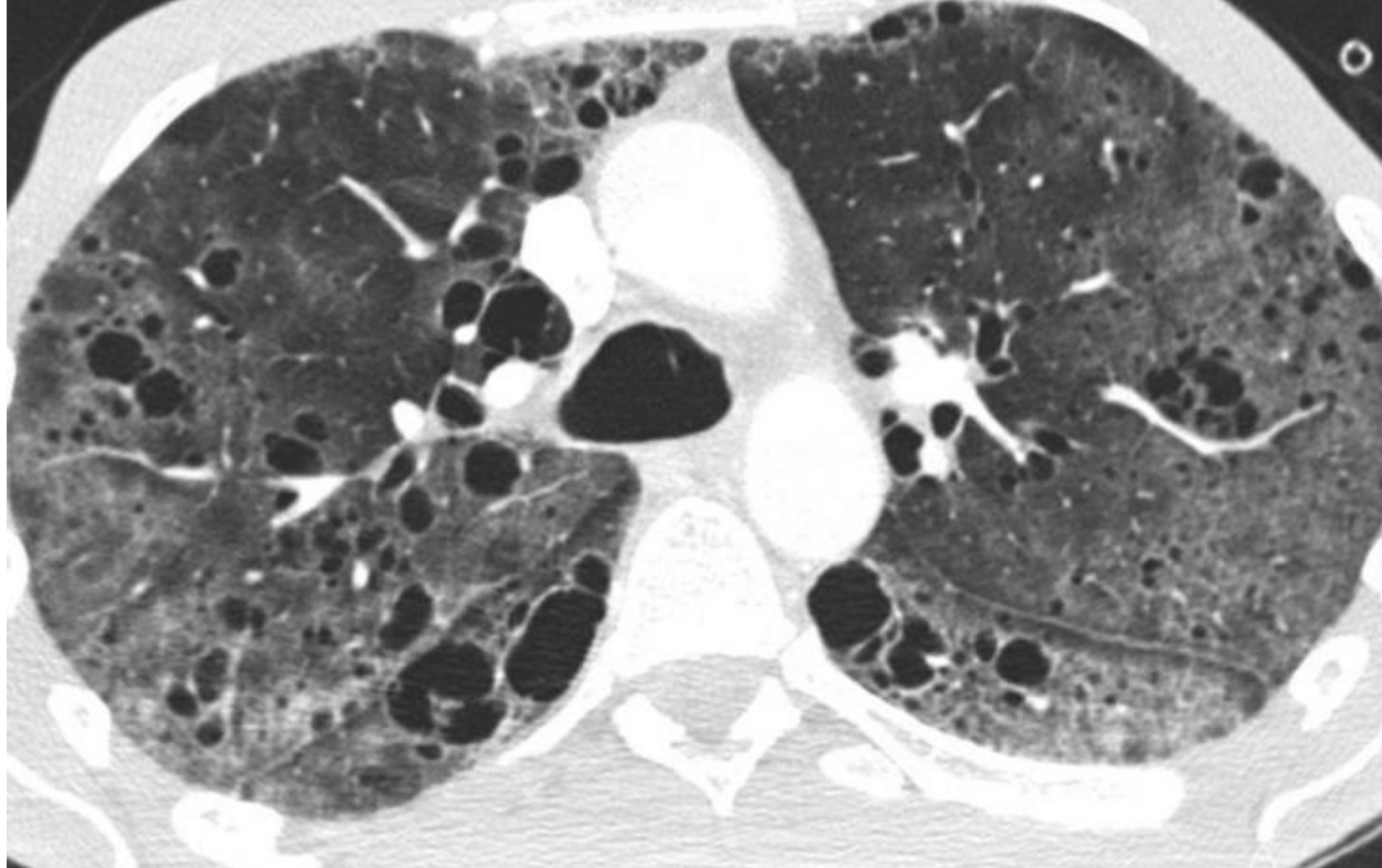
Cual **Patrón intersticial** está representado en las imagenes abajo?

Patrón Reticular



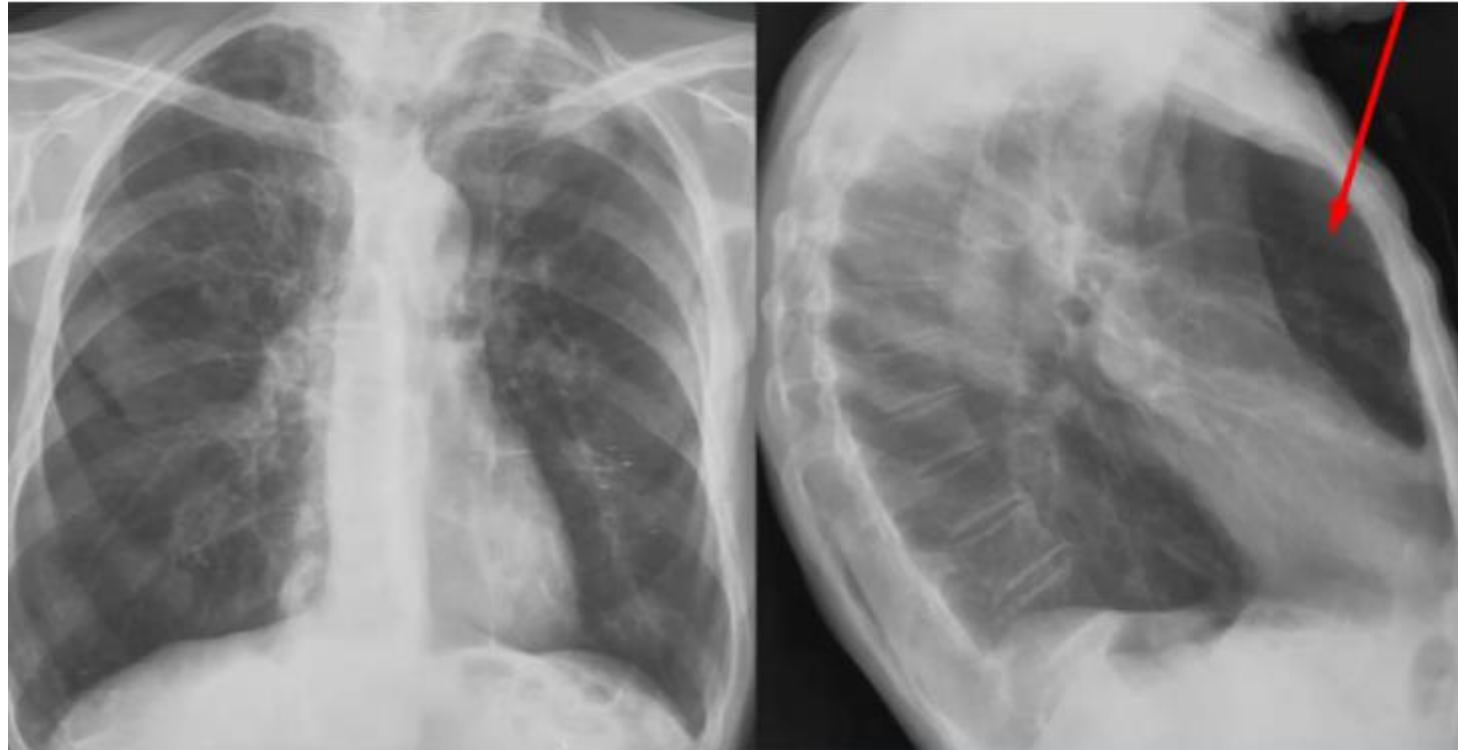
Diagnóstico presuntivo:

Absceso pulmonar



Es importante diferenciarlo de otras estructuras como cavidades (pared gruesa) o bullas (pared extremadamente delgada o ausente).

En la TC de tórax, un **Quiste** se visualiza como un espacio de bordes **bien** definidos de tamaño variable con una pared de grosor **fino**



Los Signos radiológicos de **Hiperinsuflación** (del enfisema) son:

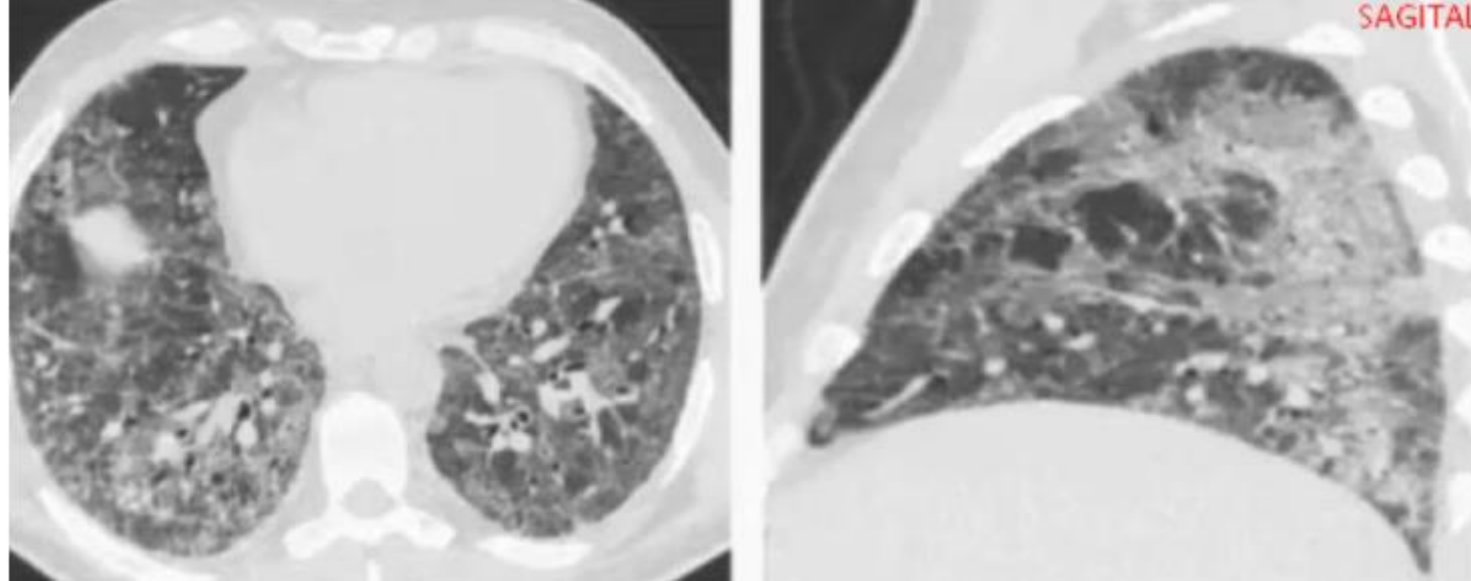
Tórax en tonel

Aplanamiento del diafragma

Horizontalización de las costillas

Aumento de los espacios intercostales

Hiperclaridad de los pulmones

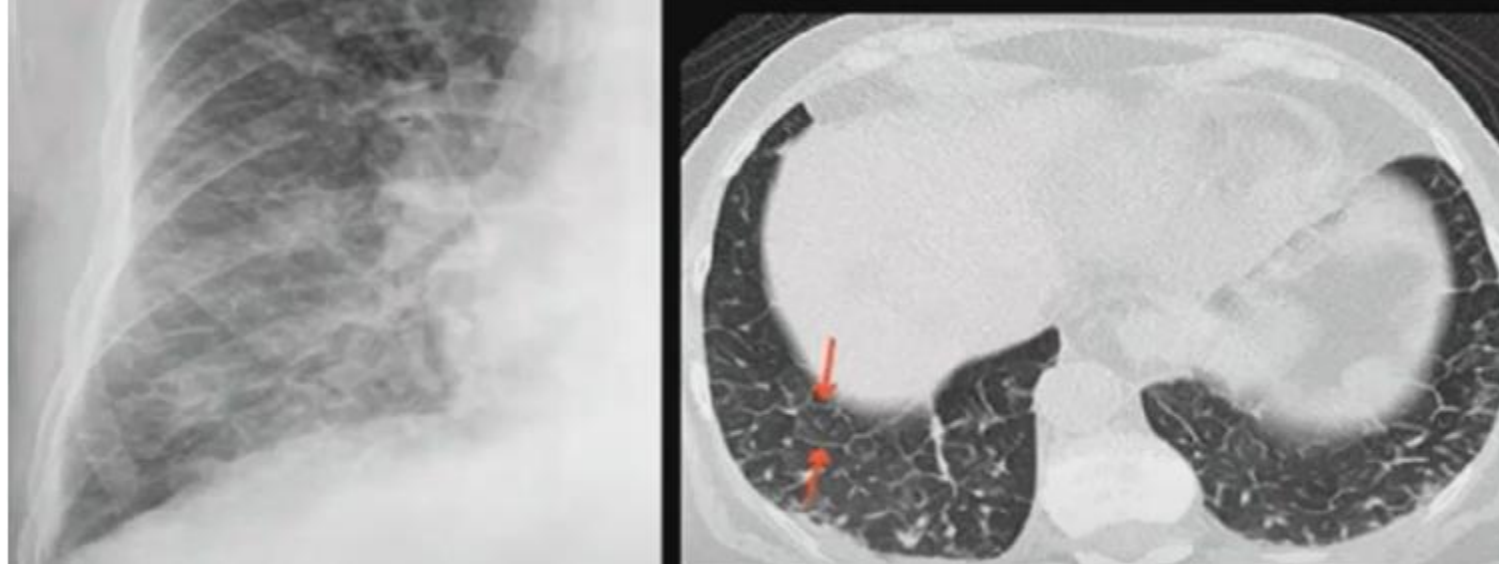


Diagnóstico presuntivo:

Neumonía Atípica

TC axial y TC Sagital torax sin contraste

TC de tórax, ventana pulmonar. Patrón interticio-alveolar donde se observan hiperdensidades heterogeneas difusas (por parches que empiezan en la periferia hacia el centro) que corresponde en **VIDRIO ESMERILADO.**



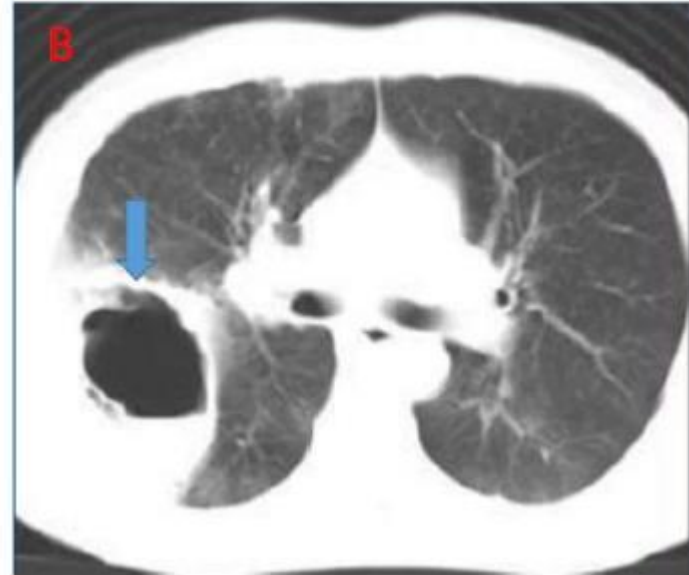
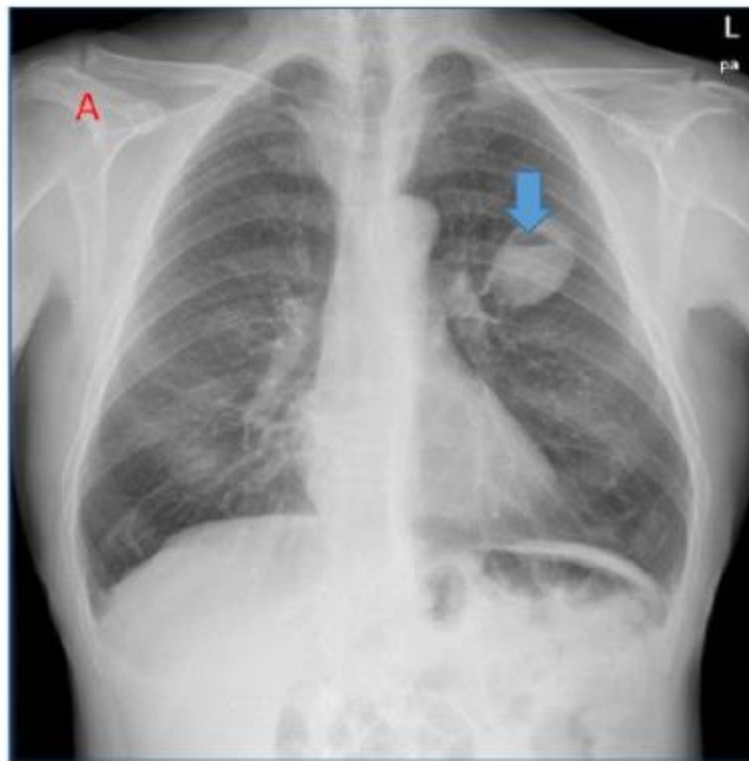
Cual **Patrón intersticial** está representado en las imagenes abajo?

Patrón Lineal

Se caracteriza por la presencia de líneas delgadas y alargadas en la radiografía o tomografía de tórax, que reflejan un engrosamiento de los septos interlobulares o intersticiales.

Causas: Edema pulmonar, linfangitis carcinomatosa.

ABSCESO PULMONAR.



Describir el Rx y la TC de tórax:

A: Rx tórax frente. En pulmón izquierdo se observa imagen redondeada radiopaca de pared gruesa con NIVEL HIDROAÉREO

B: TC tórax, ventana pulmonar, corte axial con contraste. En pulmón derecho, se observa una cavidad de paredes gruesas que en su interior presenta nivel hidroaéreo



Diagnóstico: Signo de la Silüeta **Negativo**

Opacidad mediastinal y paracardiaca izquierda de localización posterior en el hemitórax izquierdo.
NO HAY BORRAMIENTO, las estructuras son de densidades diferentes.

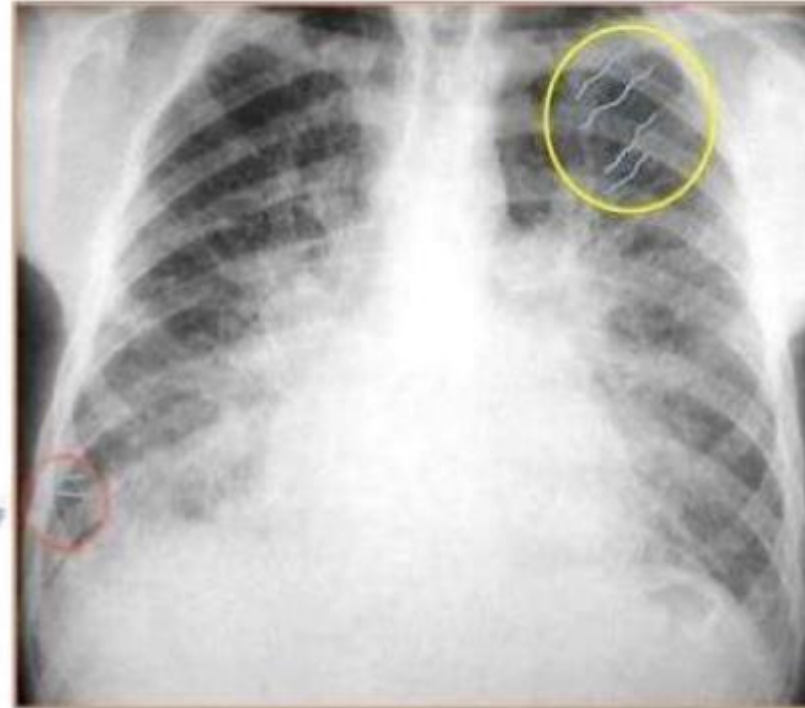


Se deben a engrosamientos de los septos interlobulares por infiltrado edematoso, neoplásico o en procesos inflamatorios.

Líneas A. Finas, largas (2-6 cm), se dirigen hacia los hilos y no contactan con la pleura. Se distribuyen en los campos superiores.

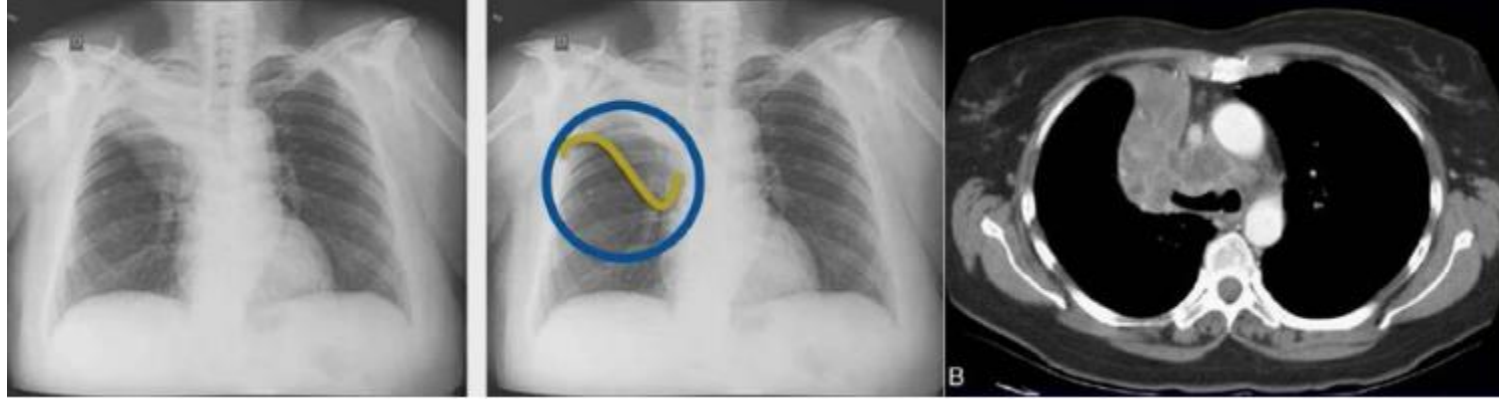
Líneas B de Kerley

Finas, cortas (2 cm largo) perpendicular a la pleura costal, se observan en las bases.



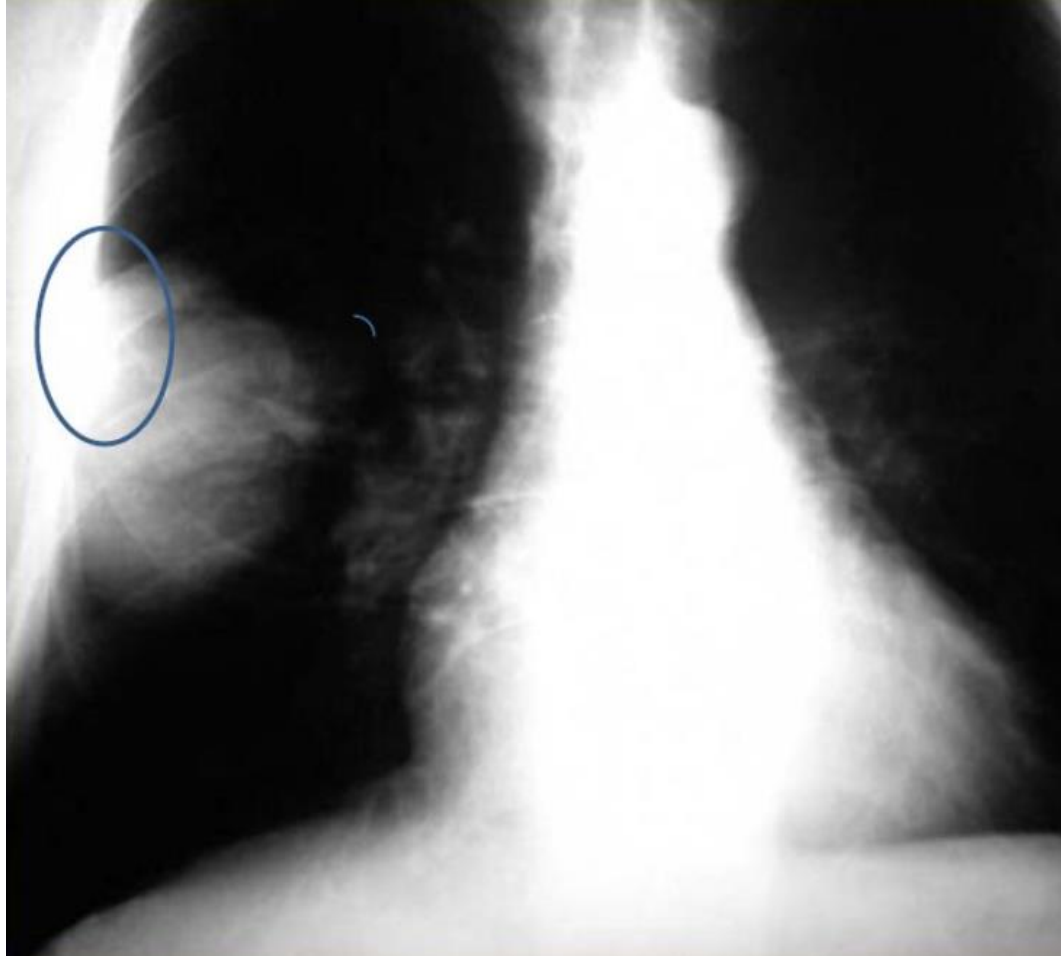
Es un engrosamiento del intersticio interlobulillar por la congestión de vasos pulmonares.

Las **Líneas de Kerley** son finas opacidades lineares visibles en algunas radiografías pulmonares, generalmente se visualiza en EAP



El **Signo de la S de Golden** es generado por la **Atelectasia** del lóbulo superior derecho que da un imagen de S itálica

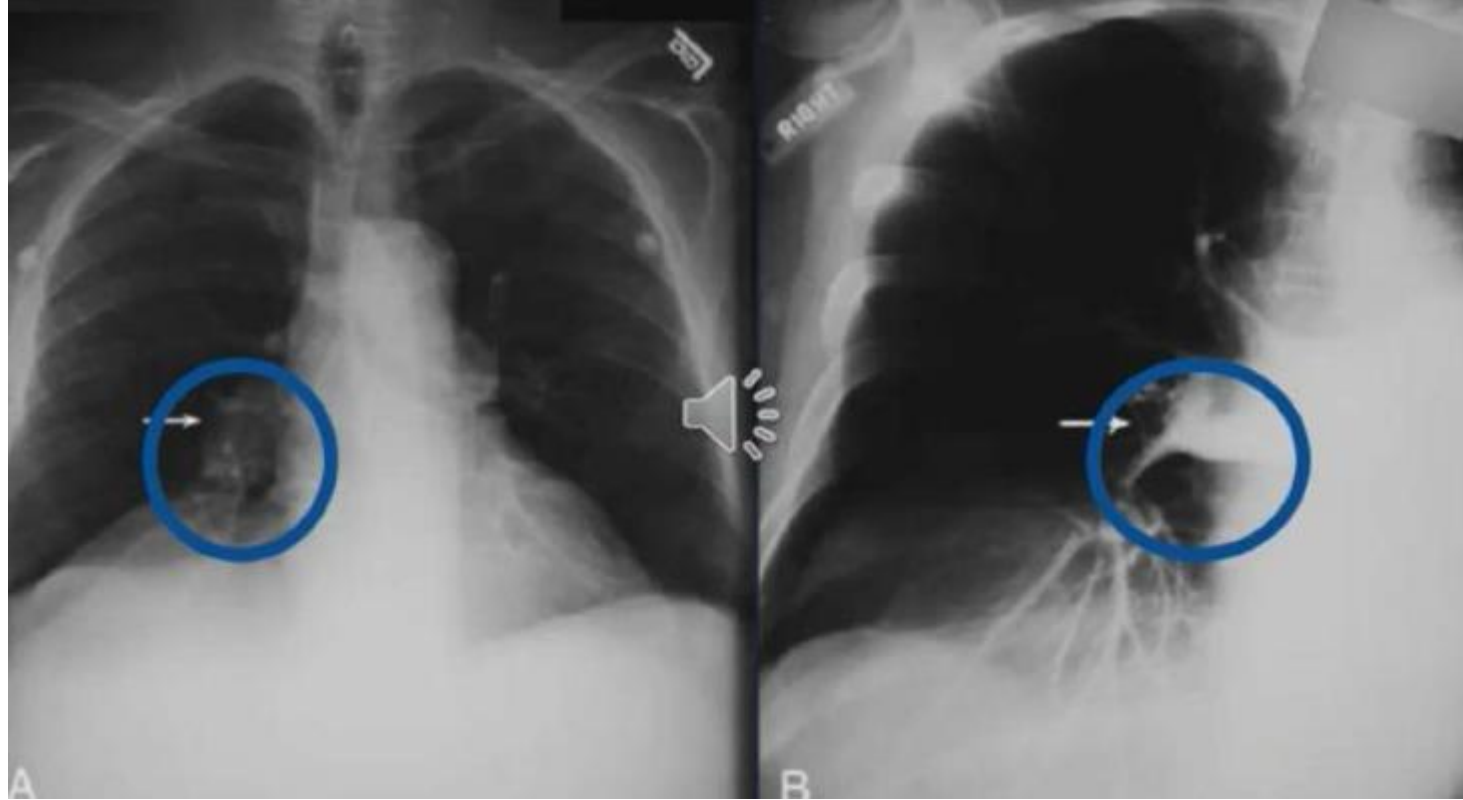
Cuando un bronquio del lóbulo superior derecho es obstruido por una lesión endobraquial, existe elevación o desplazamiento medial de la cisura menor con convexidad proximal de la cisura. Configura la imagen de S invertida o de Golden.



Las lesiones intrapulmonares, por el contrario, tienen bordes imprecisos, con ángulos agudos hacia la pleura. Es una lesión redondeada de menor campo pegada a la pleura parietal. El espacio que existe entre la pleura parietal y visceral es el espacio intrapleural o cavidad pleural. Ejemplo: Mesotelioma.

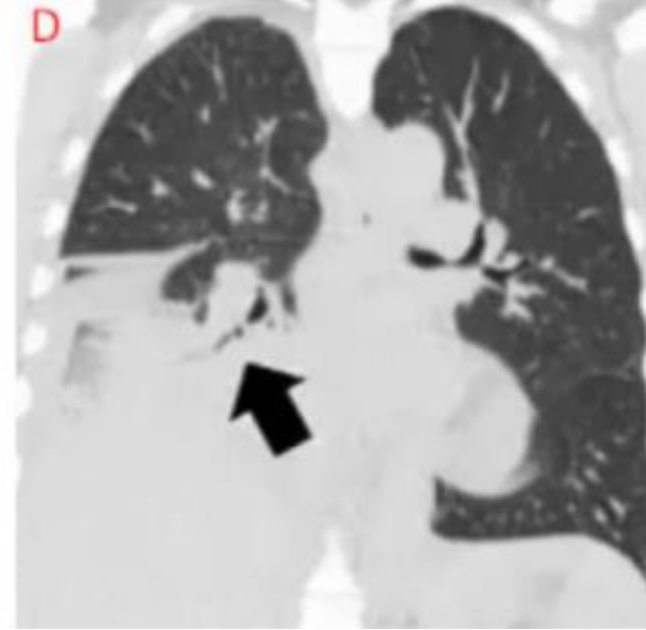
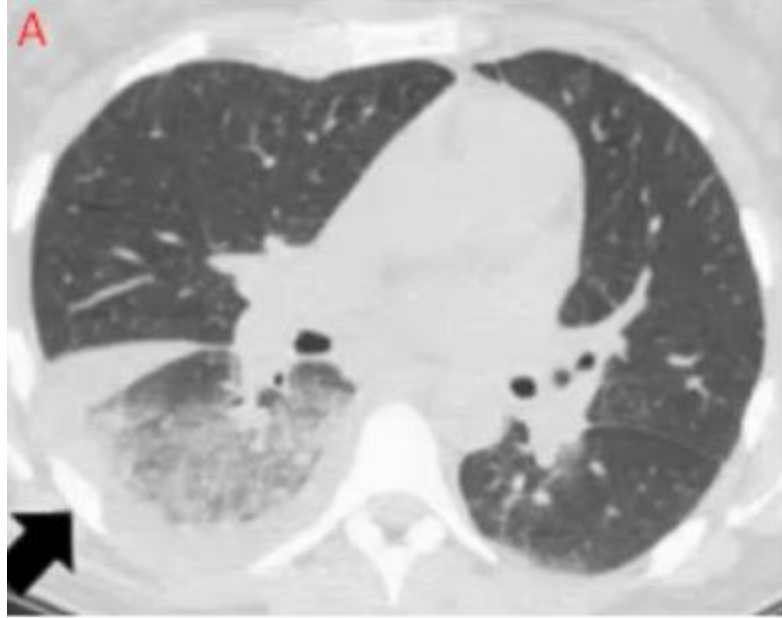
Diagnóstico presuntivo:

Lesión intrapleural



Obstrucción de las arterias pulmonares que provoca una dilatación proximal de estos vasos pulmonares y es secundario a una embolia pulmonar.

En el **Signo de Fleischner** se observa un grandamiento de las arterias pulmonares en la radiografía, generalmente secundario a embolismo pulmonar (TEP)



Diagnóstico presuntivo:

Neumonía con Derrame pleural y zona de atelectasia a nivel de la cisura

TC tórax, ventana pulmonar. Hiperdensidad heterogénea con broncograma aéreo (compatible con **neumonía**). Hiperdensidad homogéneas a nivel periférico con concavidad hacia arriba por el **derrame pleural** en pulmón derecho. Hiperdensidad homogénea en forma triangular compatible con **atelectasia**.



Cuál es el espacio extrapleural?

- Se localiza entre la pleura parietal y la caja torácica.
- Las estructuras adyacentes a esta región incluyen: tejido conectivo, nervios, vasos, músculos y costillas.

También conocido como Signo de la Embarazada.

Por el contrario, las lesiones intrapulmonares tienen borde imprecisos, con bordes agudos hacia la pleura.

En el **Signo de lesión Extrapulmonar**, las lesiones **extrapulmonares** de origen pleural o extrapleural tienen bordes **nítidos** por estar delimitadas por la pleura y forma **convexa** hacia el pulmón



No confundir con absceso
donde se ve el nivel
hidroaereo por presencia de
contenido líquido (pus,
sangre o tejido necrótico).

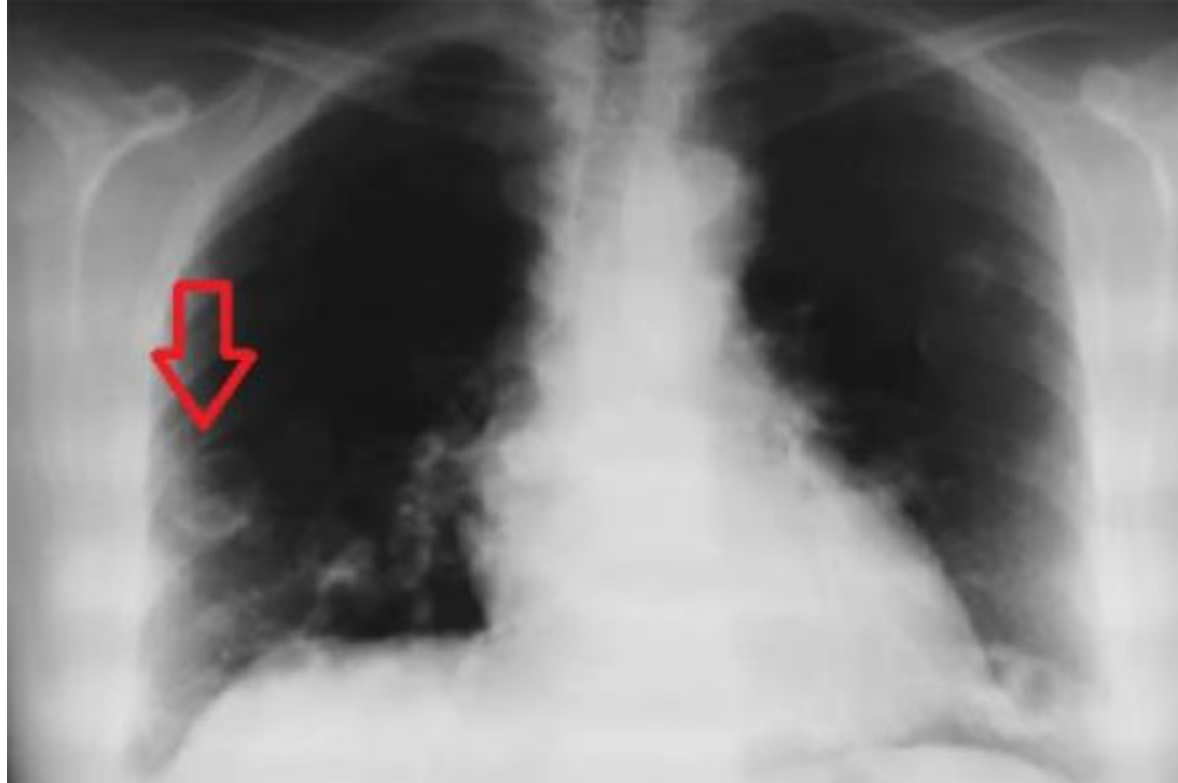
En la Radiografía, la **Cavitación pulmonar** suele tener
una pared **gruesa** y un margen interno irregular



Característico de
NEUMOMEDIASTINO (presencia de
aire a nivel del mediastino)

Cómo se observa el **Signo del diafragma continuo** en el Rx
tórax?

**Se observa una línea continua de hiperlucidez extendiéndose
a lo largo de la línea media, por encima del diafragma**



Diagnóstico presuntivo:

Caverna pulmonar

CAVERNA: Rx de tórax frente donde se observan en ambos campos pulmonares varias lesiones radiolucientes con halo radiopaco que corresponde provablemente a MTS, embolia septica o TBC.

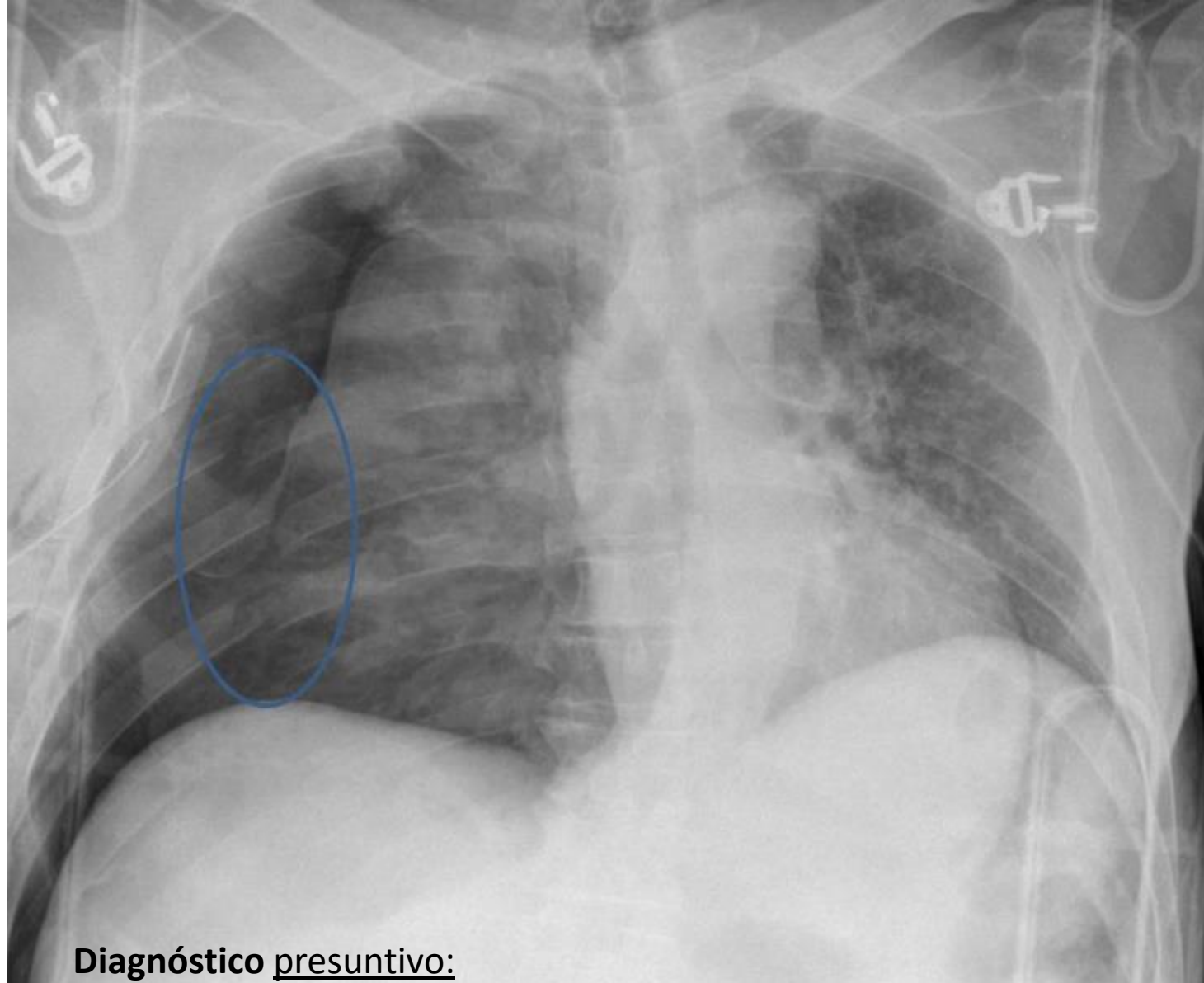


Quando las estructuras tienen diferentes densidades, no hay borramiento. En este caso conseguimos ver el límite que las separan.

Quando 2 estructuras de densidades diferentes presentan una **interfase** entre ellas con un límite que las separa y las define, a esto se conoce como **Signo de la Silueta NEGATIVO**

¿Qué es el SIGNO DE SILUETA POSITIVO?

Dos estructuras en contacto directo que tienen intensidad que no se permite diferenciarlas



Diagnóstico presuntivo:

Múltiples fracturas costales y neumotórax

MASA MEDIASTINAL

Arterias pulmonares ocultas por masa tímica que hace silueta con el borde cardíaco izquierdo.



CARDIOMEGALIA

Desplazamiento de la arteria interlobar derecha sin superponerse a ella (flecha amarilla).



Sirve para DIFERENCIAR una CARDIOMEGALIA de una MASA DEL MEDIASTINO ANTERIOR.

En el Signo del hilio oculto cuando hay **cardiomegalia**, el agrandamiento cardíaco **desplaza** a los hilos y cuando es una **masa mediastinal** **superpone** a los hilos

BRONCONEUMONÍA.



Describir que se ve en la TC de tórax abajo:

A nivel de la flecha se observa un patrón de **ÁRBOL EN BROTE** que corresponde a hiperdensidad en la pequeña vía aérea, lo que sugiere engrosamiento de los bronquiolos terminales en pulmón izquierdo

**Masa mediastínica anterior
(SIGNO CERVICOTORACICO)**



**Masa mediastínica posterior
(ultrapasa clavículas)**



En caso de sobrepasar la clavícula, se encuentra la lesión en mediastino posterior.

El **Signo Cervicotorácico** se basa en que las estructuras del mediastino ANTERIOR no sobrepasan el nivel de las clavículas en la **Radiografía de tórax**



Rx tórax frente. Presencia de una densidad oval o redonda que presenta límites. Es más frecuente en la infancia (es dx diferencial con nódulo).

Diagnóstico presuntivo:

Neumonía redonda



No es una placa
patológica, sino que la
paciente tiene prótesis.
Importante preguntar al
realizar el exámen.

Diagnóstico presuntivo:

Prótesis mamária



En el **Signo del aire creciente**, se observa una colección de aire de forma **periférica** que rodea un área central necrótica de infección.

Generalmente se asocia a infecciones por aspergilosis pulmonar invasiva.

Imagen de la izquierda: Vemos una radiografía de tórax con una radiopacidad redondeada y alo radiolúcido.

Imagen de la derecha: Vemos una tomografía de tórax con ventana pulmonar y vemos una imagen hiperdensa redondeada con un alo hipodenso.

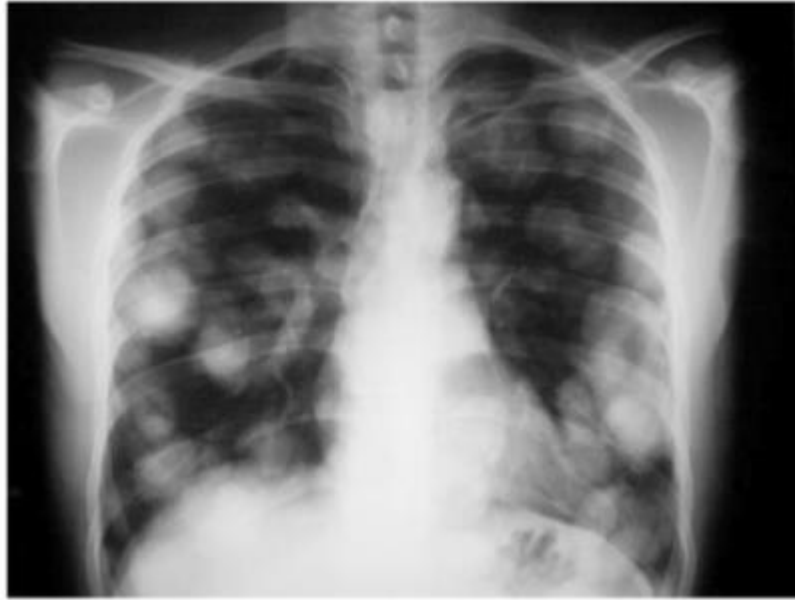


Rx tórax frente. Hay un BLOQUE NEUMÓNICO que indica consolidación (opacidad heterogénea) con broncograma aéreo a nivel del Lóbulo Superior (en su segmento posterior).

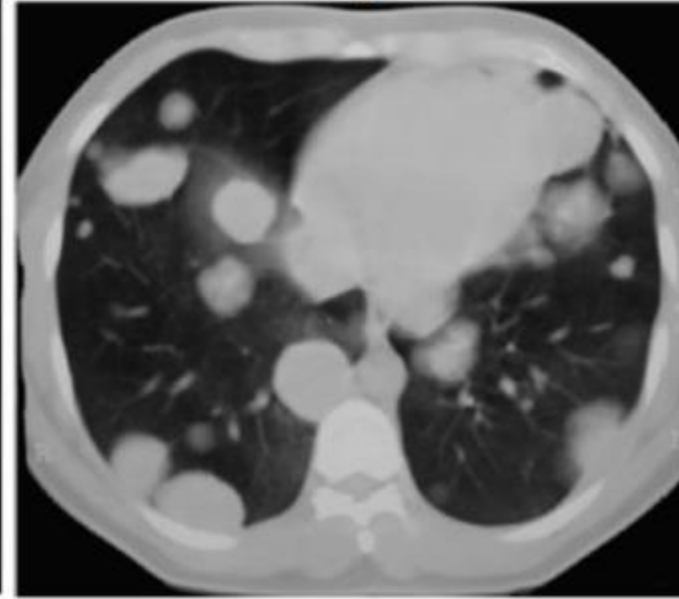
Diagnóstico presuntivo:

Neumonía

Rx tórax frente



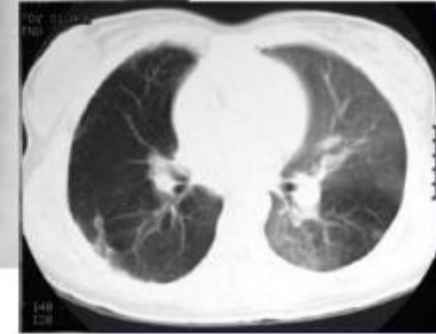
TC ventana pulmonar



La presencia de múltiples nódulos pulmonares bien definidos de distribución bilateral, aleatoria y de diferentes tamaños, sugerente de **metástasis pulmonares** representa el **Signo de la suelta de globos**



El signo de Westermark, es una asociación de opacidad del parénquima causada por oligohemia y agrandamiento hilar, provocado por el alojamiento del émbolo en la arteria pulmonar. Podemos observarlo en pacientes con TEP sin infarto.



Se ve en casos de TEP.

Se ve radiolúcido en Rx porque hay disminución o ausencia de líquido en la zona señalada.

Ya en la TC se ve una hipodensidad.

El **Signo de Westermark** se observa cuando hay **regiones de oligohemia** en la periferia del parénquima pulmonar



Diagnóstico: Signo de la Silueta **Positivo**

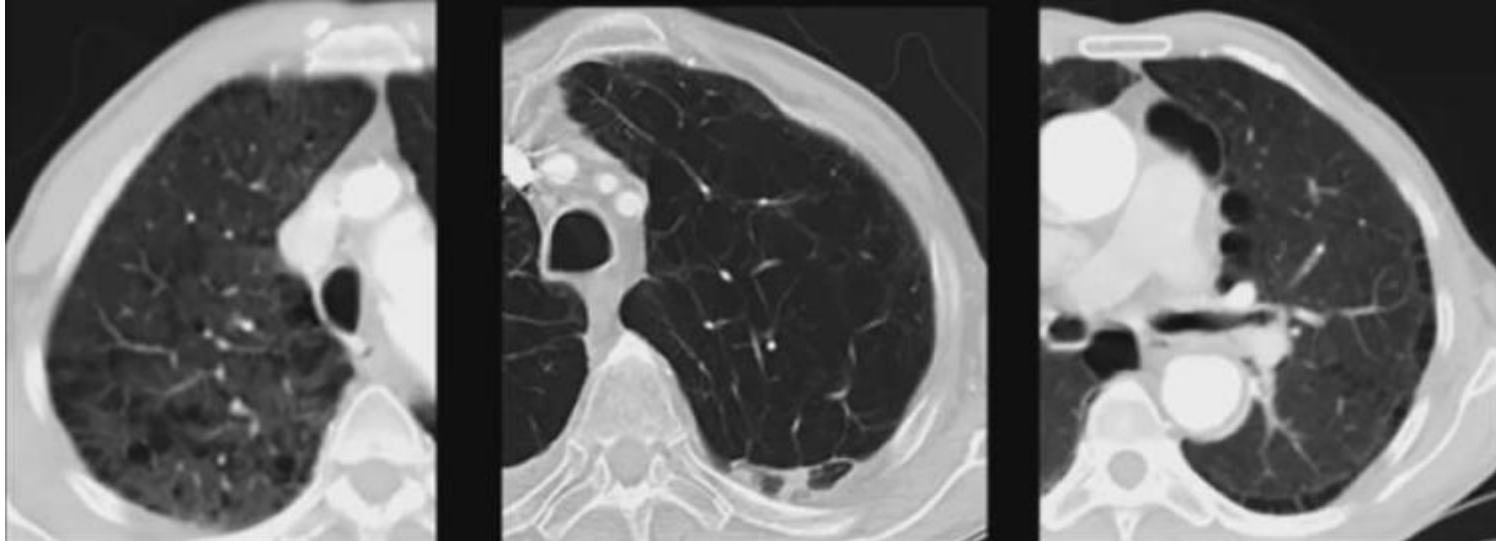
Opacidad pulmonar, radioopacidad intratorácica, que está en contacto anatómico con el borde cardíaco, la aorta o el diafragma, y borrará su contorno.



Tc de tórax con ventana pulmonar, corte axial.
Patrón en vidrio esmerillado (opacidades heterogéneas en ambos campos pulmonares con predominio intersticio-alveolar).

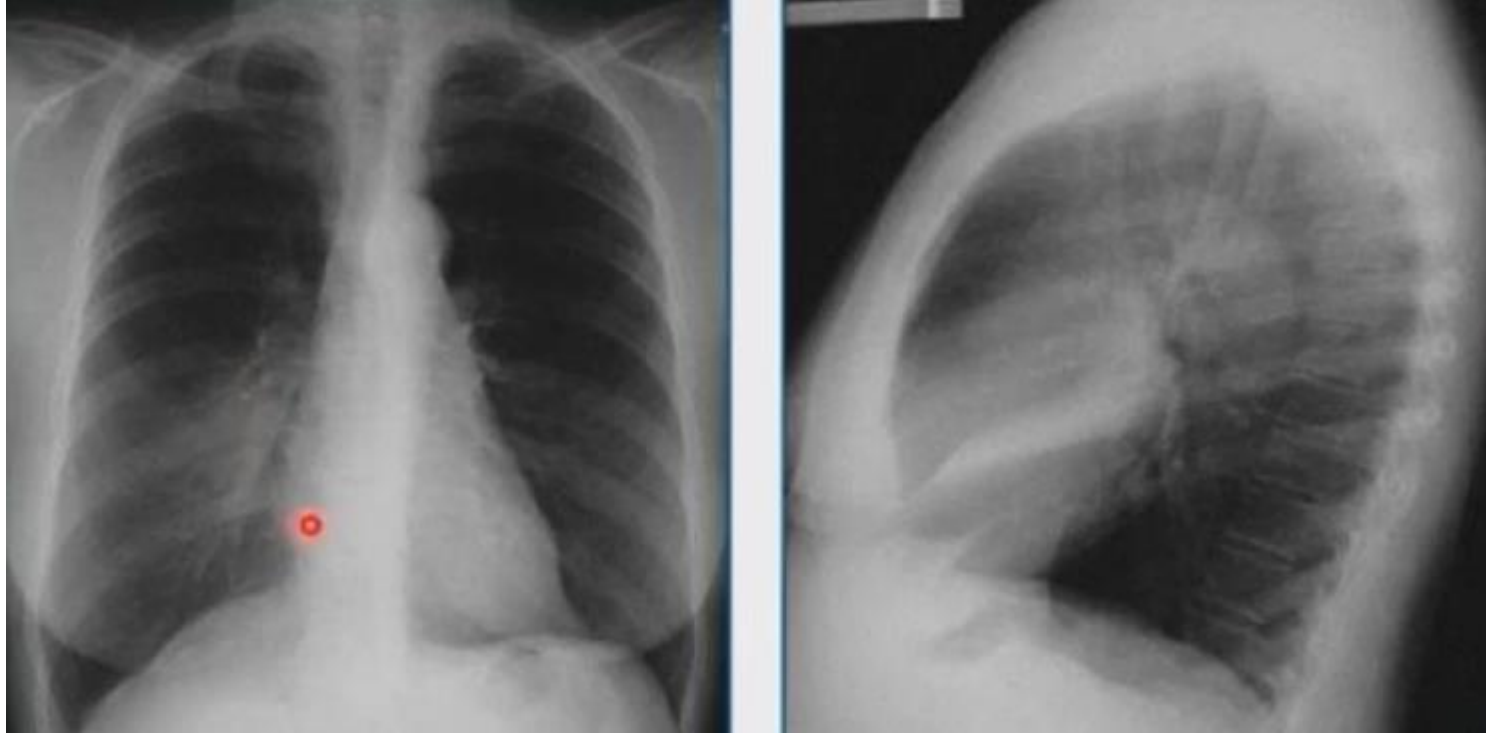
Diagnóstico presuntivo:

Neumonía Atípica



Las **Bullas** son espacios aéreos **mayores a 1 cm** que pueden ser subpleurales o intraparenquimatosos y tienen paredes **finas**

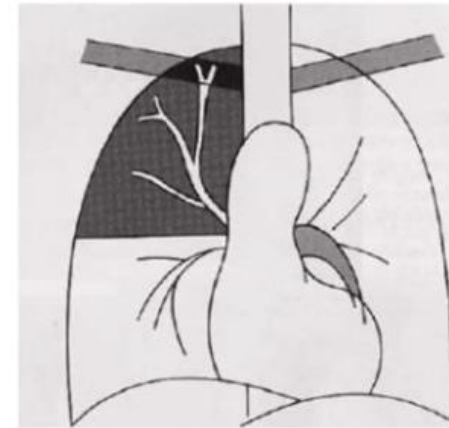
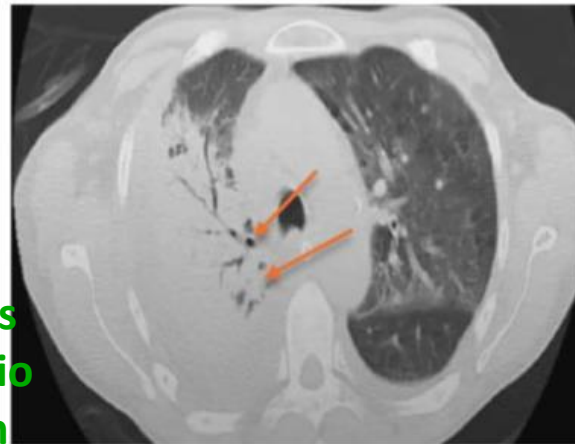
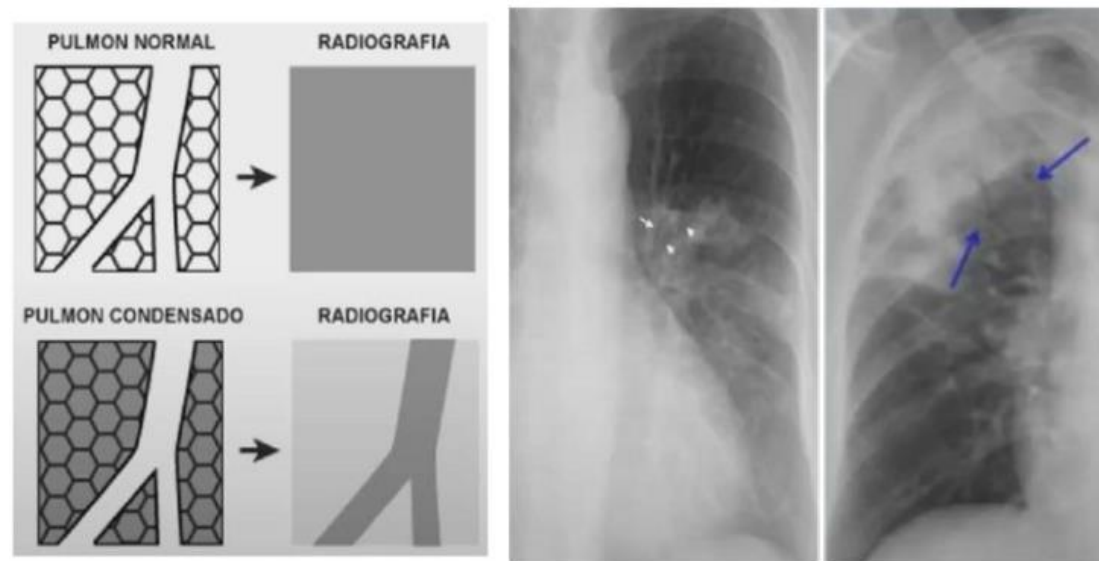
Hay que saber bien para hacer dx diferencial con linfangioleiomiomatosis y quistes.



El Rx de perfil es de gran utilidad para identificarlo (se observa entre las cisuras).

Diagnóstico presuntivo:

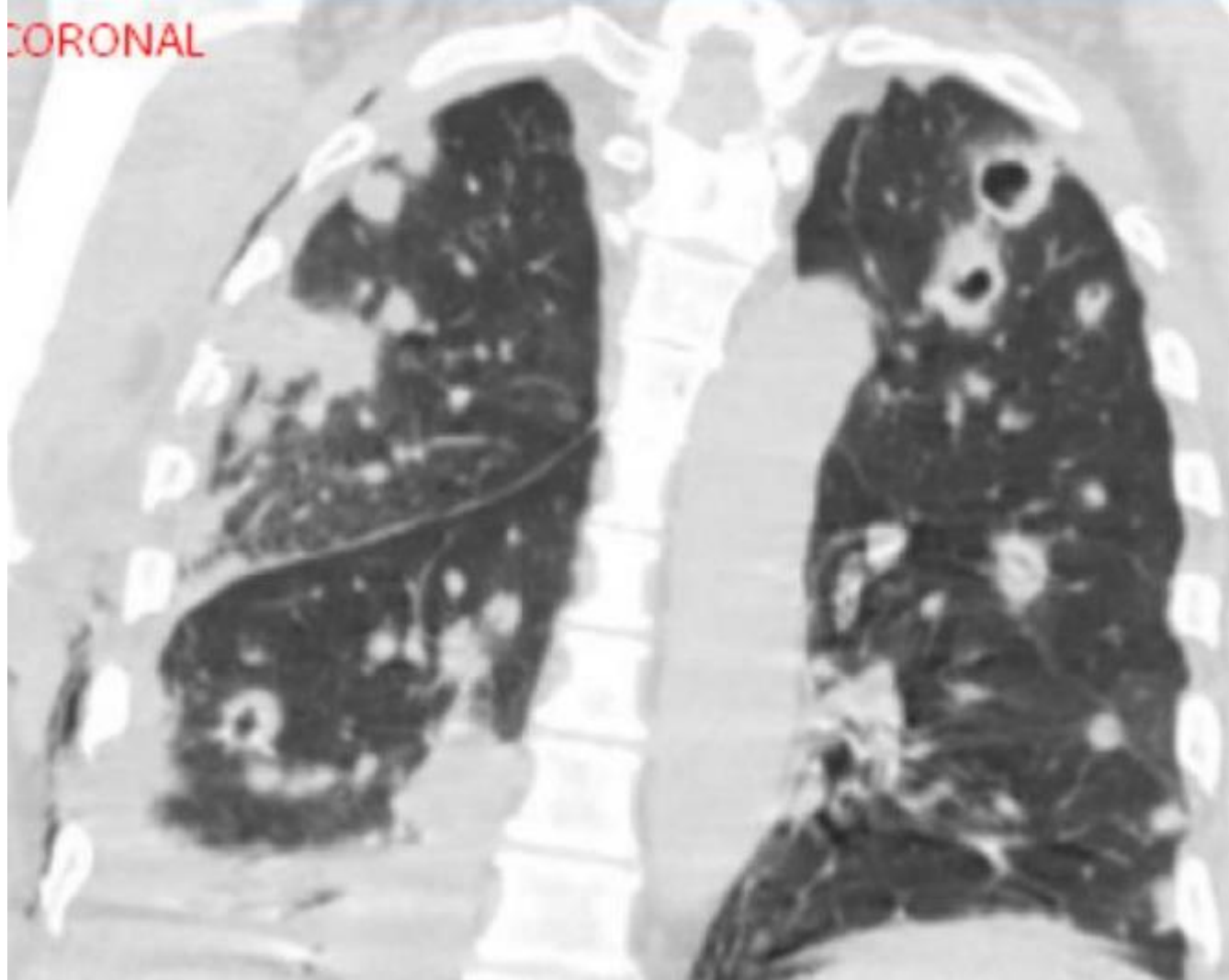
Atelectasia lóbulo medio derecho



En un Rx no son visibles los bronquios intrapulmonares dado que el bronquio y el tejido pulmonar que lo rodea son de la misma densidad aérea. Pero cuando hay alguna patología que condensa el parénquima, se puede visualizar los bronquios llenos de aire (radiolúcido) y el parénquima condensado (radiopaco).

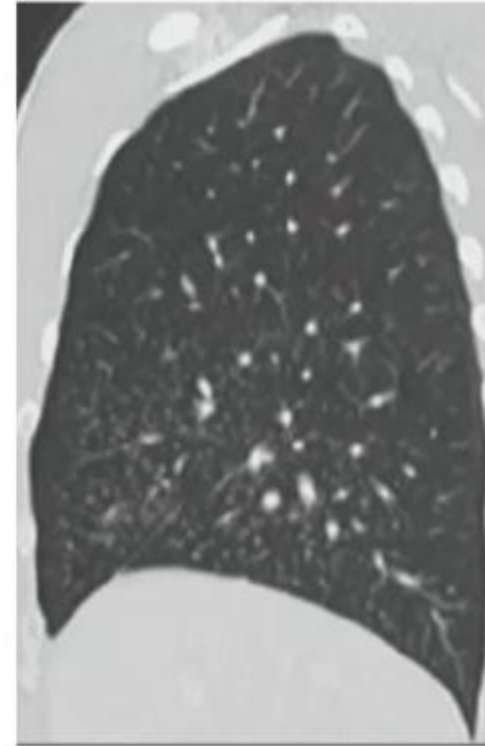
En el **Signo del broncograma aéreo**, el aire en los alveolos es reemplazado por agua, sangre o pus que son **radiopacos** y el bronquio se visualiza como **estructura tubular radiolúcida**

TC de tórax, ventana pulmonar, corte coronal. Múltiples nódulos diseminados en ambos pulmones con CAVIDADES (halo hiperdenso y interior hipodenso) y nódulos sólidos (hiperdenso).



Diagnóstico presuntivo:

Embolia séptica



Se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos (muy chiquititos), que son opacidades redondeadas y pequeñas, distribuidas en el pulmón.

Causas: Neumoconiosis, TBC miliar, sarcoidosis, histiocitosis, hongos.

Cual **Patrón intersticial** está representado en las imagenes abajo?

Patrón Nodular

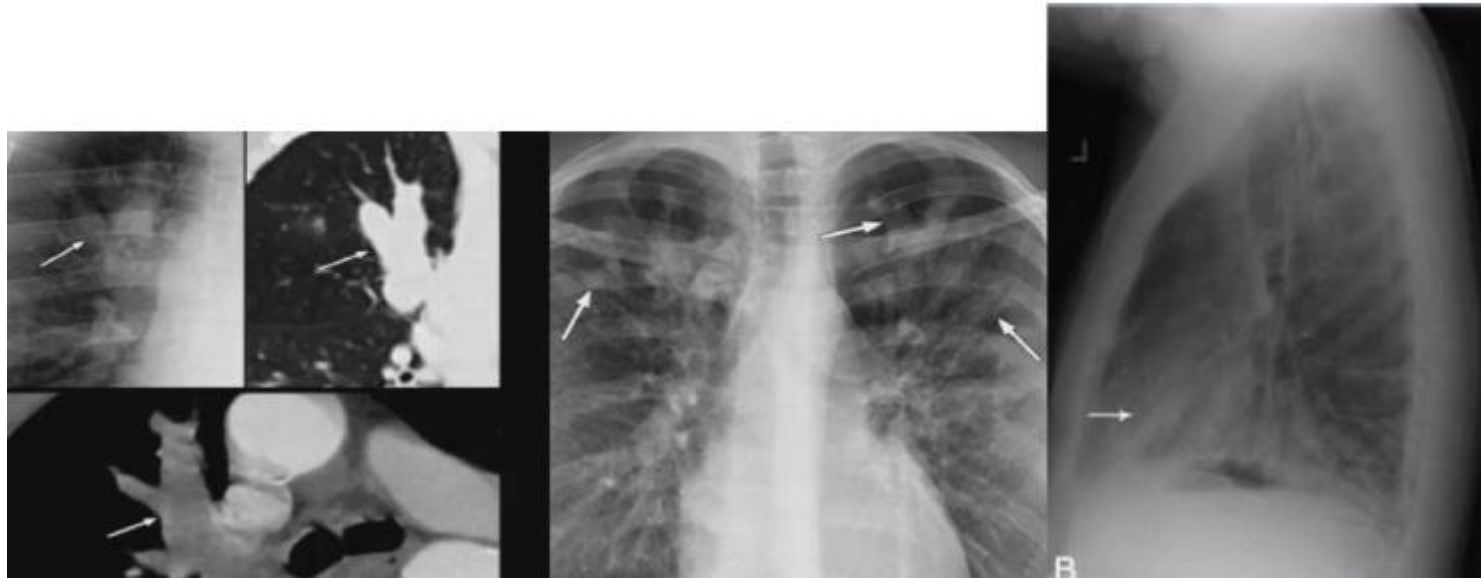


Diagnóstico presuntivo:

Histiocitosis pulmonar

Más común en varones y está relacionada a hábito tabáquico, caracterizada por la presencia de múltiples imágenes quísticas de paredes finas con distribución a predominio en lóbulos superiores.

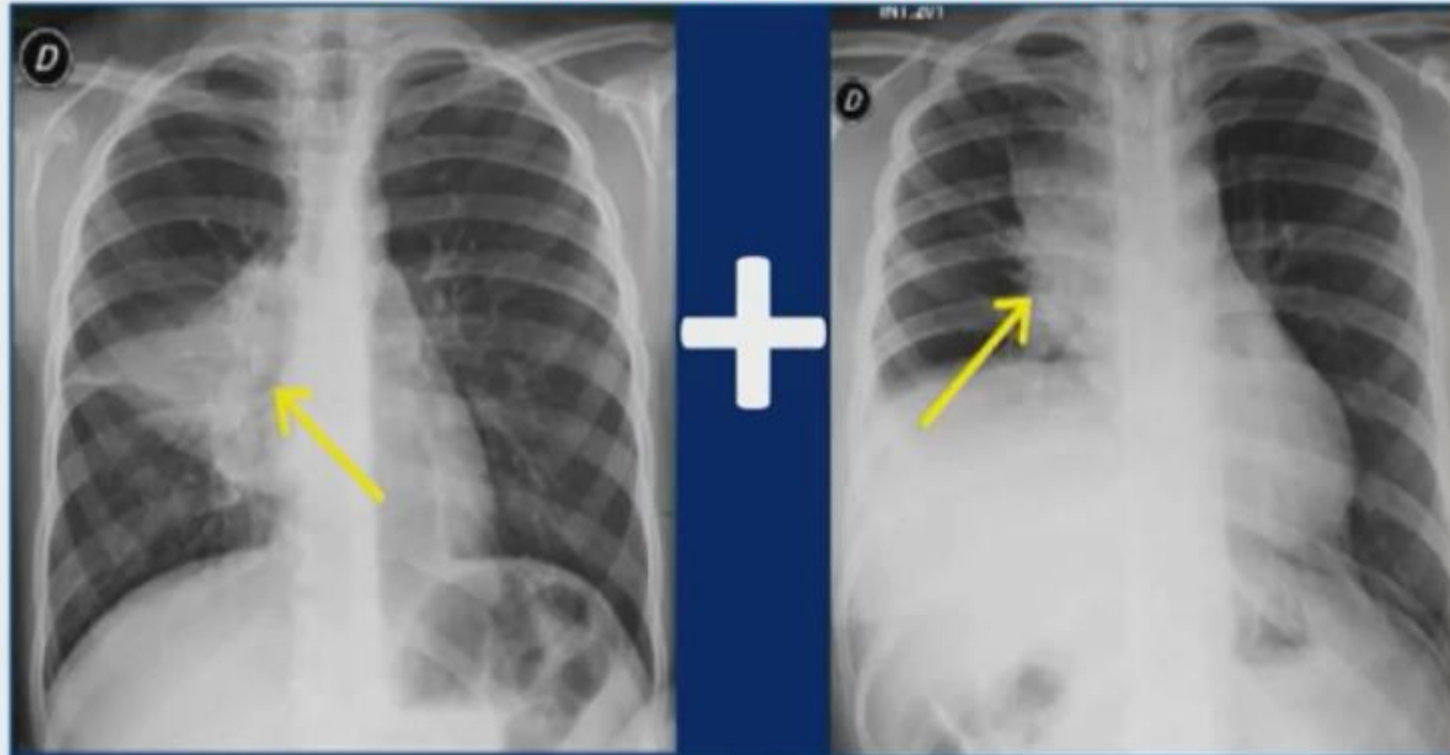
La linfangioleiomiomatosis es a predominio en mujeres y lóbulos inferiores.



Se observa por ejemplo en
asma, fibrosis quística,
aspergilosis broncopulmonar.

El Signo del dedo de guante indica que los bronquios están
dilatados con impactación mucosa

SIGNO DE SILUETA POSITIVA



Qué es el **Signo de la Silueta** POSITIVO?

Es cuando 2 estructuras de la MISMA densidad están en contacto entre sí, lo que lleva a un BORRAMIENTO de los límites de ambas estructuras

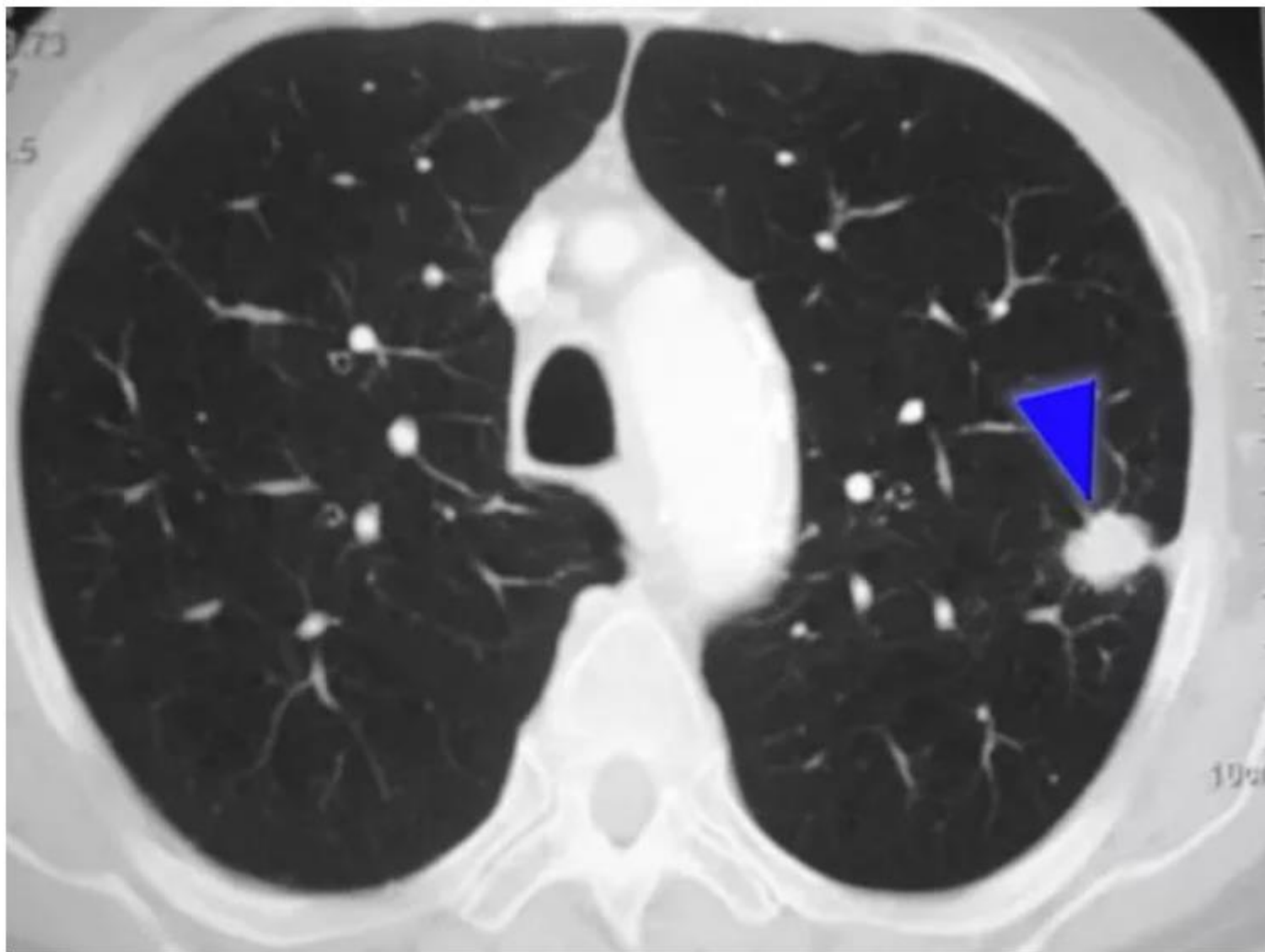


Rx tórax

Diagnóstico presuntivo:

Derrame pleural

Tc con ventana
pulmonar, se
visualiza en pulmón
bordes lobulados



Diagnóstico presuntivo:

Nódulo pulmonar

Signo de Golden. Imagen en S invertida



Diagnóstico presuntivo:

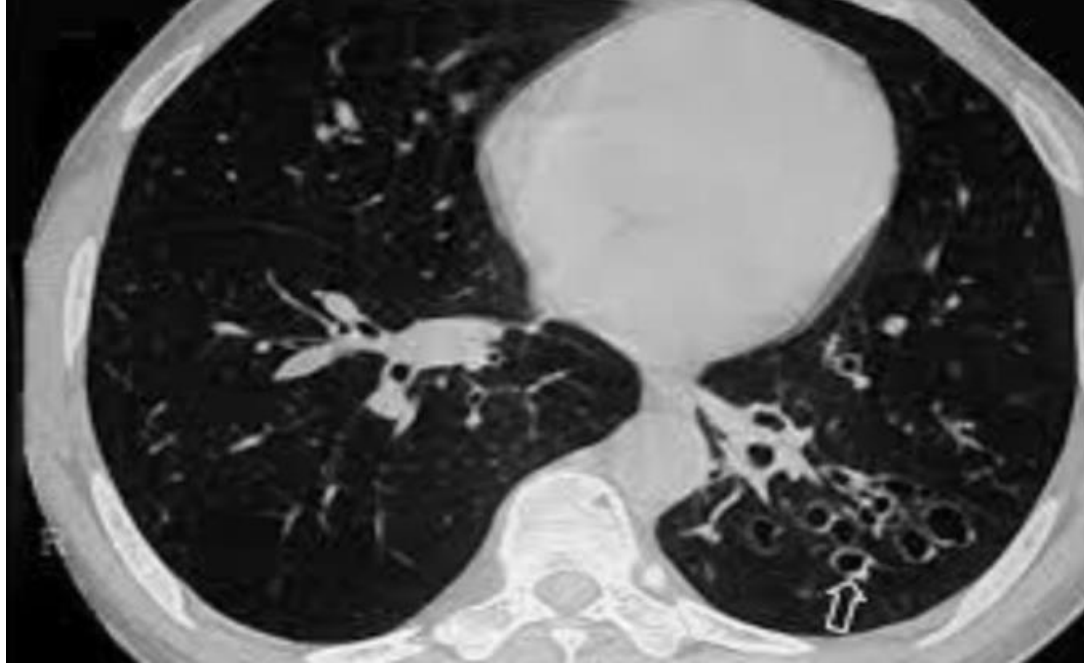
Atelectasia del lóbulo superior derecho

RX de tórax con
Radiopacidad basal derecha
de bordes definidos



Diagnóstico presuntivo:

Tumor fantasma



Patrón intersticial, se puede observar un patrón de panal de abejas con signo de anillo de sello

Diagnóstico presuntivo:

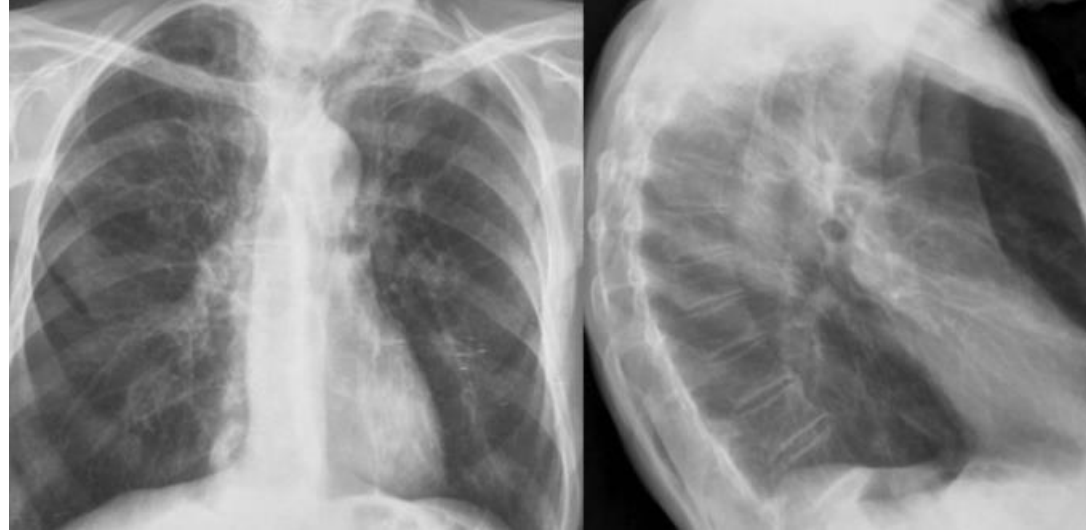
Bronquiectasia

Recuerde que el liquido se va a la base pulmonar y el aire sube al ápice



Porque se toma **radiografia de tórax** de un paciente parado?

Para ayudar en la visualización de líquido (derrame pleural por ejemplo) y aire (en neumotórax por otro ejemplo)

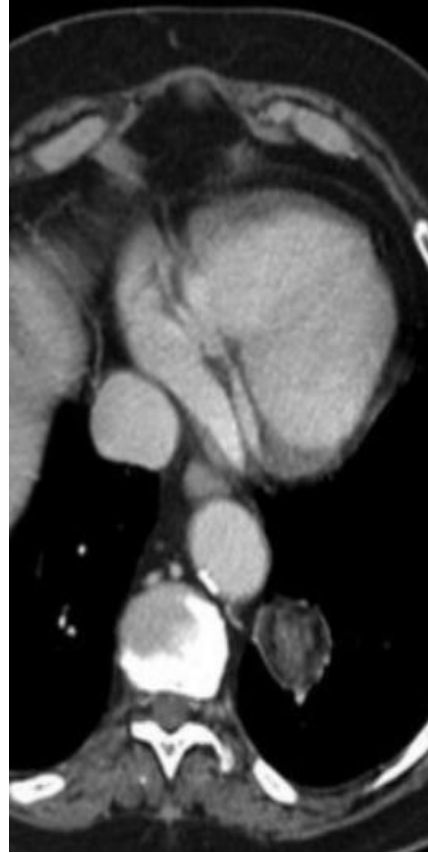


Diagnóstico presuntivo:

Enfisema pulmonar

Rx de tórax frente y perfil, presentan signos semiológicos de la enfermedad obstructiva crónica con hiperinsuflación y tórax en tonel

TC ventana mediastínica, se ve una imagen nodular ubicada en la base izquierda que presenta áreas grasas en su interior



Diagnóstico presuntivo:

Hemartroma pulmonar



Descripción de la imagen:

TC ventana pulmonar broncograma aéreo

En la consolidación parenquimatosa los bronquios se ven porque el aire de sus luces hace contraste con el pulmón opaco que los rodea. Se ve en neumonía, edema pulmonar, infarto pulmonar, linfoma pulmonar y adenocarcinoma bronquioloalveolar



Patrón intersticial en el lóbulo derecho se ve la presencia de
aire en la cavidad pleural con posterior colapso pulmonar

Diagnóstico presuntivo:

Neumotórax



Diagnóstico presuntivo:

Bullas pulmonares

TC ventana pulmonar, se observa un patrón intersticial y visualiza bullas en el lóbulo inferior derecho. Imágenes aéreas redondeadas mal delimitadas, pared muy fina



Diagnóstico presuntivo:

Caverna tuberculosa

Se ve en el lóbulo pulmonar derecho, en zona parahiliar un
imagen redondeada con paredes gruesas y presencia de aire,
indicativo de caverna tuberculosa



Diagnóstico presuntivo:

Patrón intersticial

Rx de tórax frente



Como se llama el siguiente **signo**?

Signo de la vela

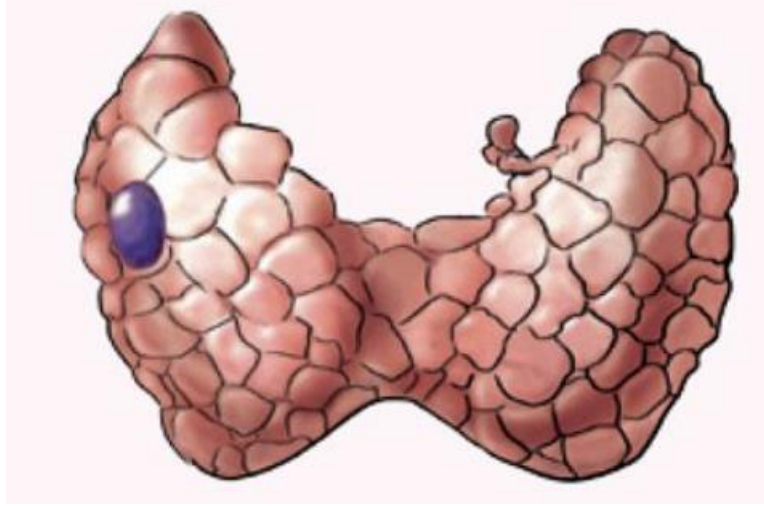
Opacidad triangular de tejido tímico que se proyecta hacia la derecha o izquierda y a veces ambas direcciones



Nombre el signo:

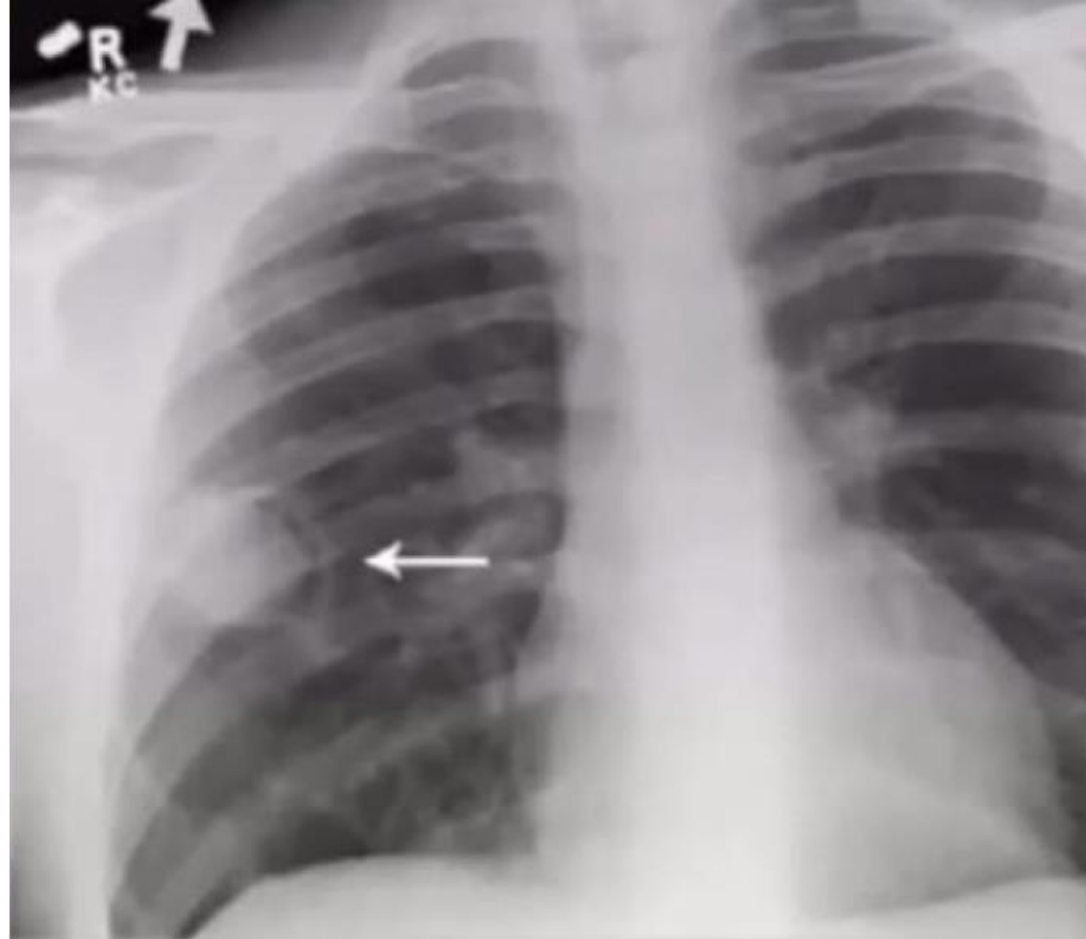
Dedo de guante

Aumento de radiopacidad por infecciones, lo que generan
hipersecreción bronquial



Cuanto tiempo un **nódulo** tiene que mantenerse en el mismo tamaño para que sea considerado **Benigno**?

2 anos con el mismo tamano



Nombre el siguiente **signo**:

Signo del aire creciente

Presente en abscesos pulmonares, neoplasias cavitadas,
infecciones por TBC



Nombre el siguiente **signo**:

Signo del diafragma continuo

Línea continua de hiperlucidez extendiendose a lo largo de la línea media, por encima del diafragma



Diagnóstico presuntivo:

TBC miliar

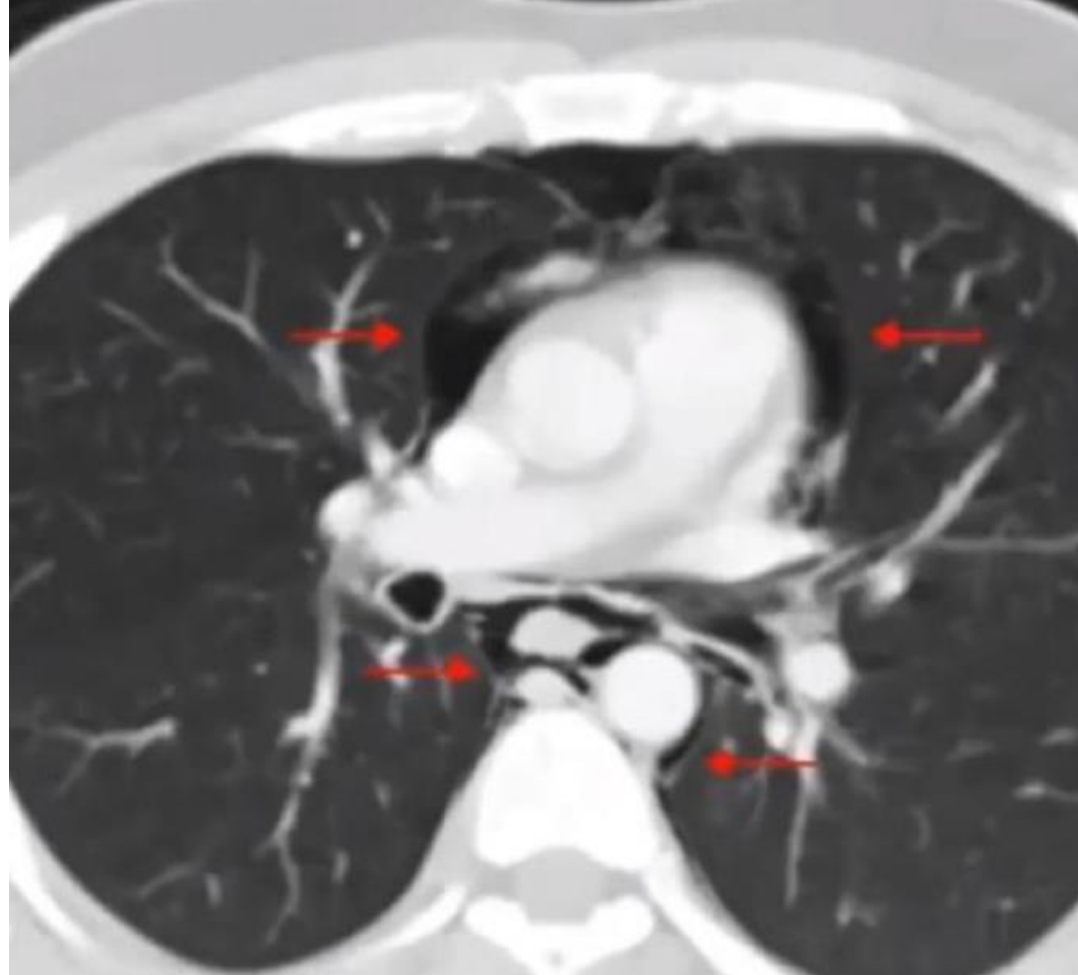
Opacidades en Arbol en brote



Diagnóstico presuntivo:

TBC postprimaria

Tomografia computada



Diagnóstico presuntivo:

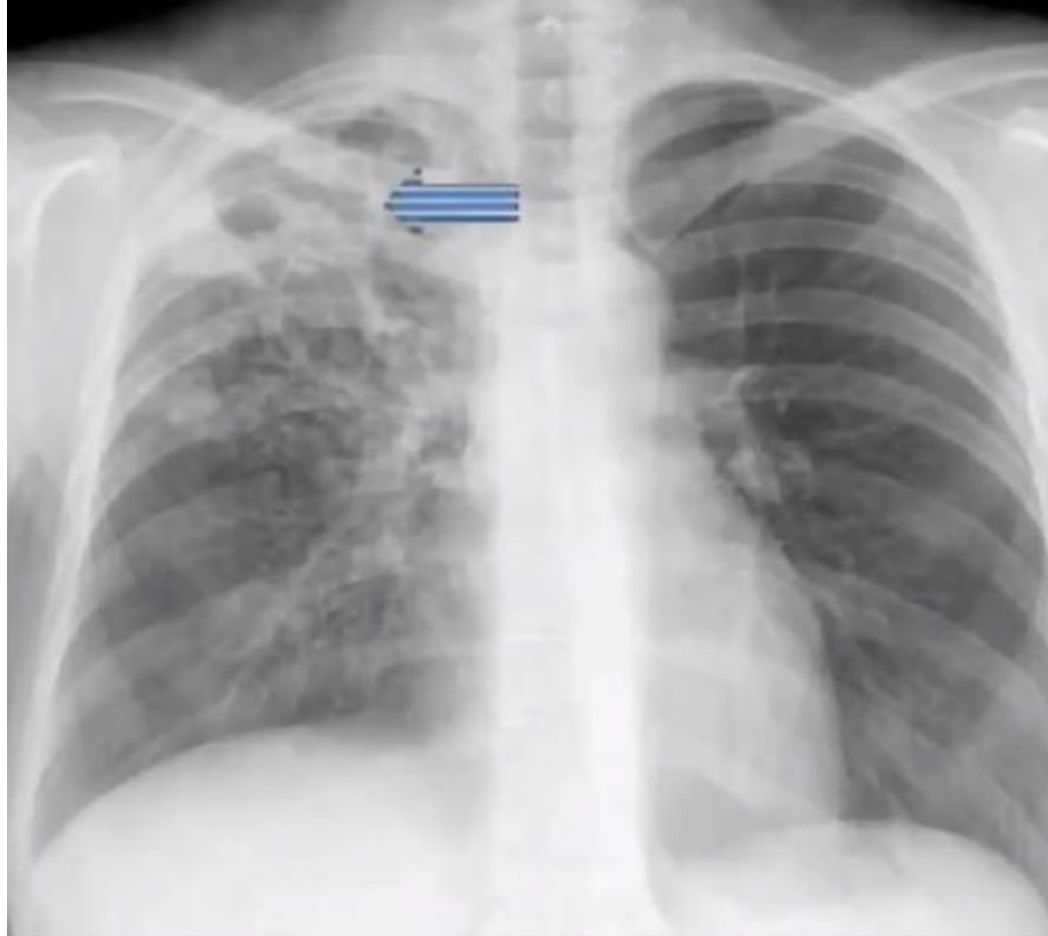
Neumomediastino

Engrosamiento del
intesticio interlobulillar por
la congestión de vasos
pulmonares



Nombre el signo:

Líneas B de kerley



Diagnóstico presuntivo:

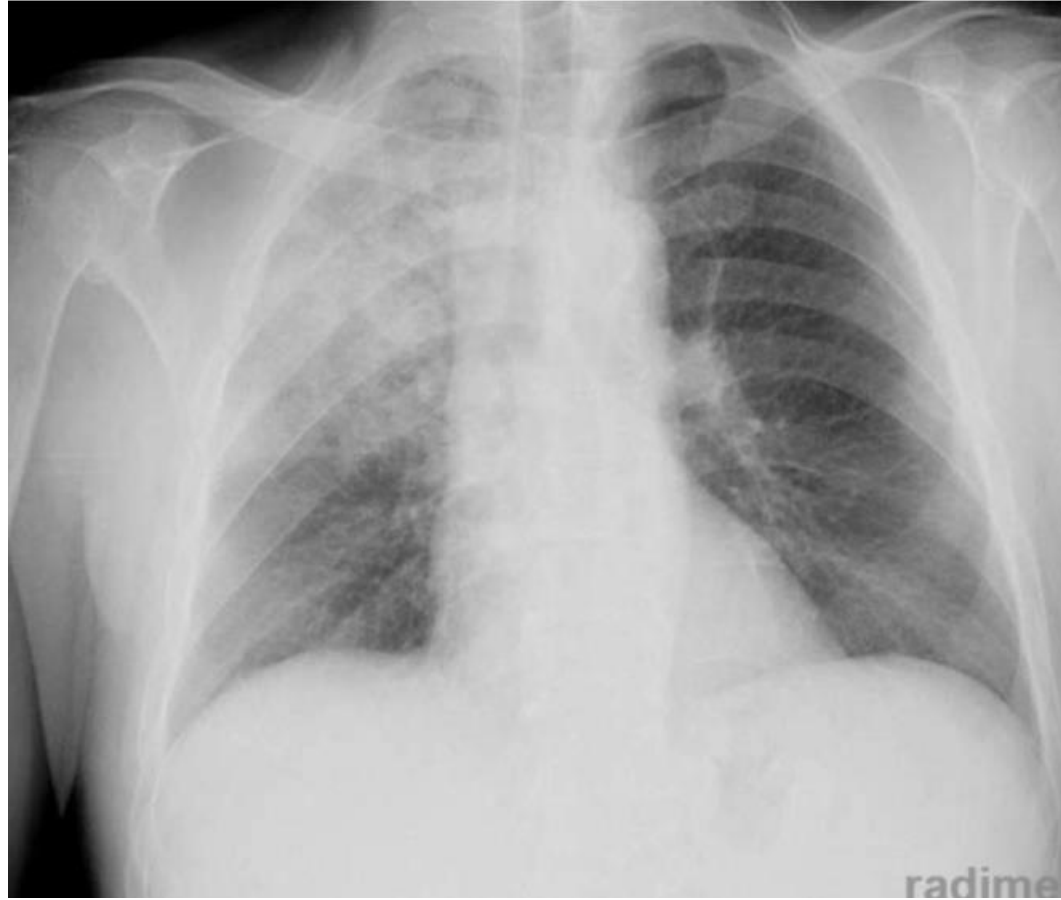
Caverna pulmonar

**Extensa consolidación en el lobulo superior derecho,
parcialmente cavitada, que asocia a pérdida de volumen de
dicho lóbulo**



Diagnóstico presuntivo:

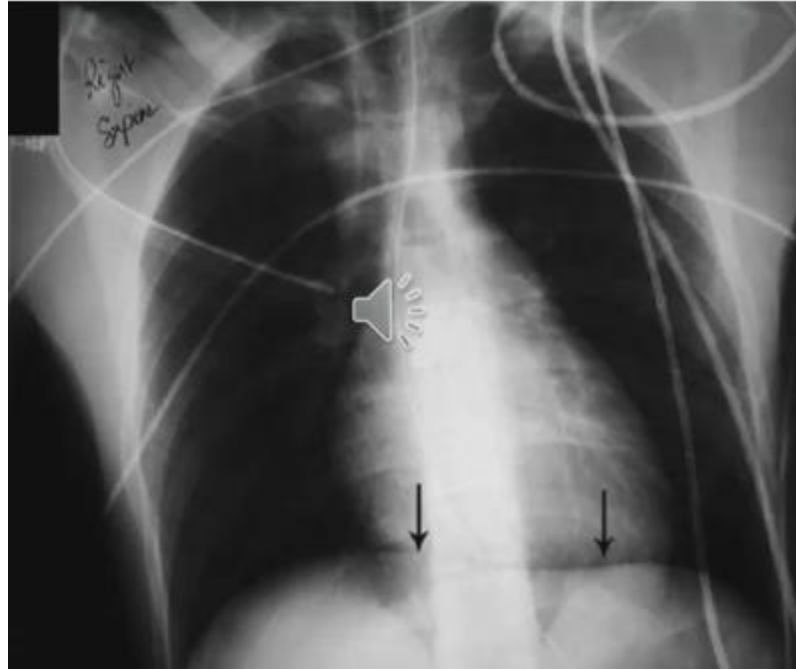
Atelectasia masiva



Diagnóstico presuntivo

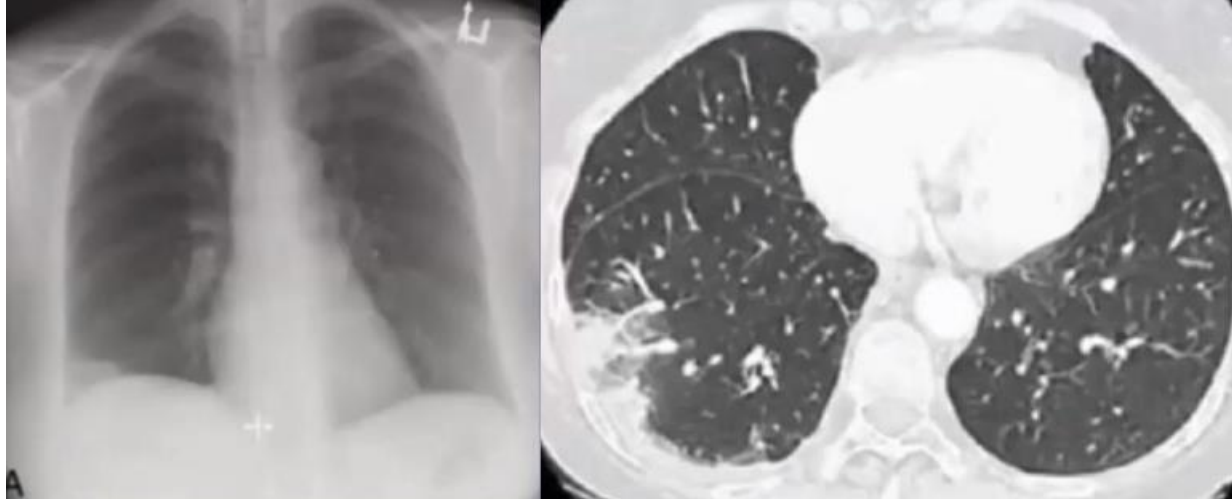
Neumonía de lobulo superior derecho

Rx de tórax de frente con radiopacidad en el lóbulo superior derecho, con signo del broncograma aéreo. Indicativo de neumonía LBD



Diagnóstico presuntivo:
Neumomediastino

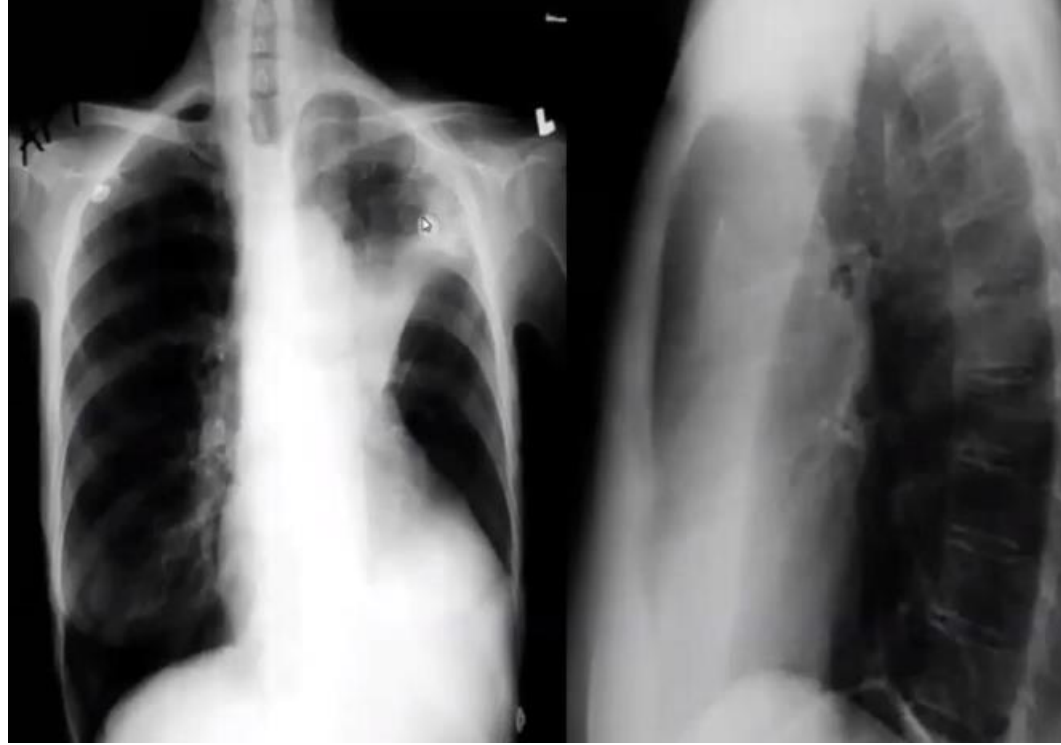
Línea continua de hiperlucidez extendiéndose a lo largo de la línea media, por encima del diafragma. Signo del diafragma continuo, característico de neumomediastino.



Nombre el **signo**:

Jaroba de Humpton

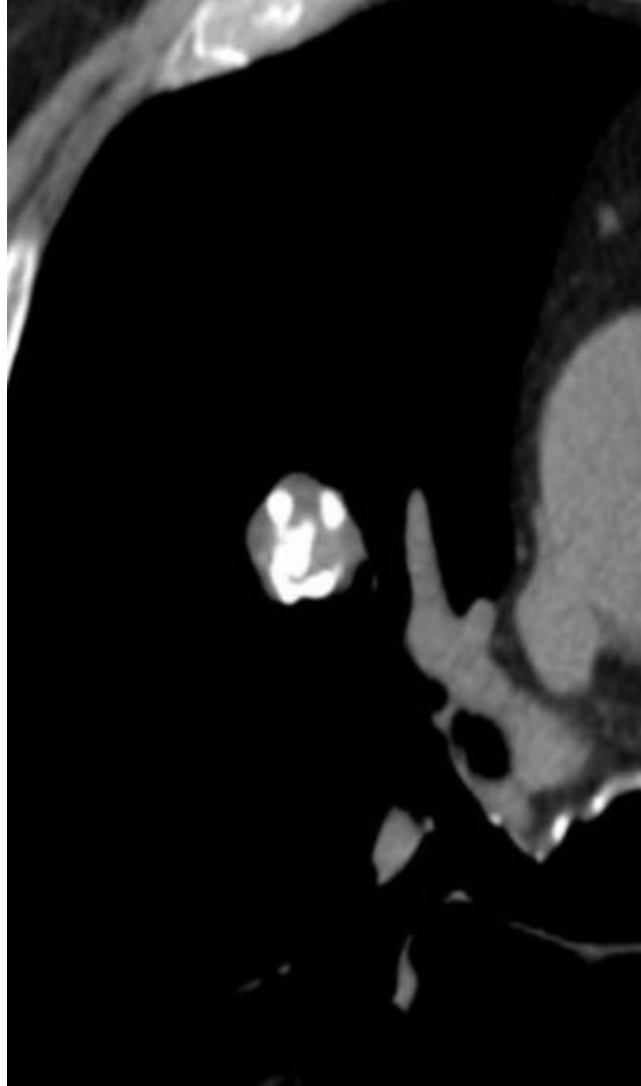
En RX de tórax, presenta una imagen radiopaca. Se genera un pico en la zona de la pleura más cercana al diafragma, se puede observar en infarto pulmonar, neoplasia pulmonar y derrame



Diagnóstico presuntivo:

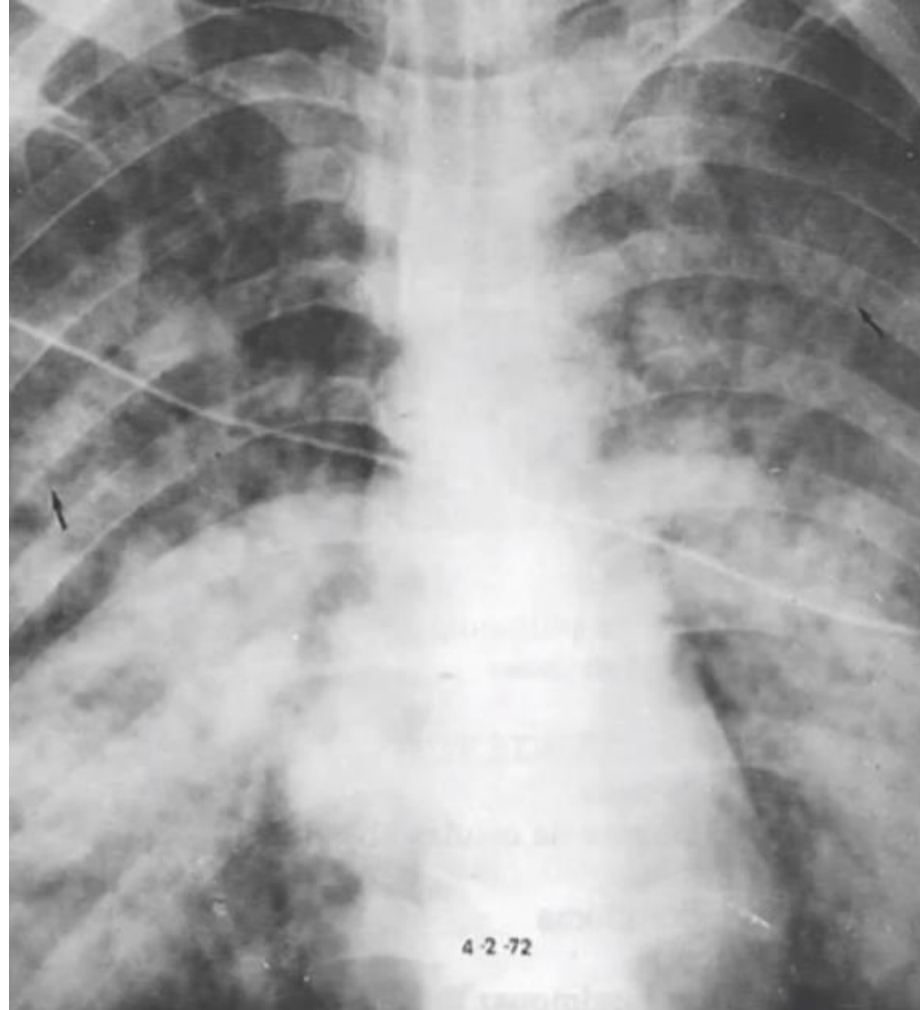
Atelectasia lobulo superior izquierdo

Radiopacidad homogenea



Diagnóstico presuntivo:
Hemartoma pulmonar

Tc ventana mediastinica, imagen nodular ubicada en situacion parahiliar derecha que presenta areas calcicas en "pochoclo" o popcorn.



Diagnóstico presuntivo:

Edema de pulmón

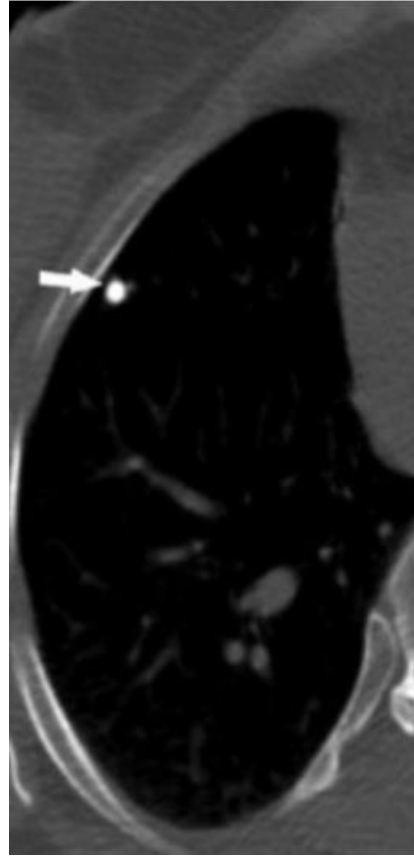
RX de tórax, se observa patrón intersticial con radioopacidad de bordes algodonosos bilaterales



Diagnóstico presuntivo:

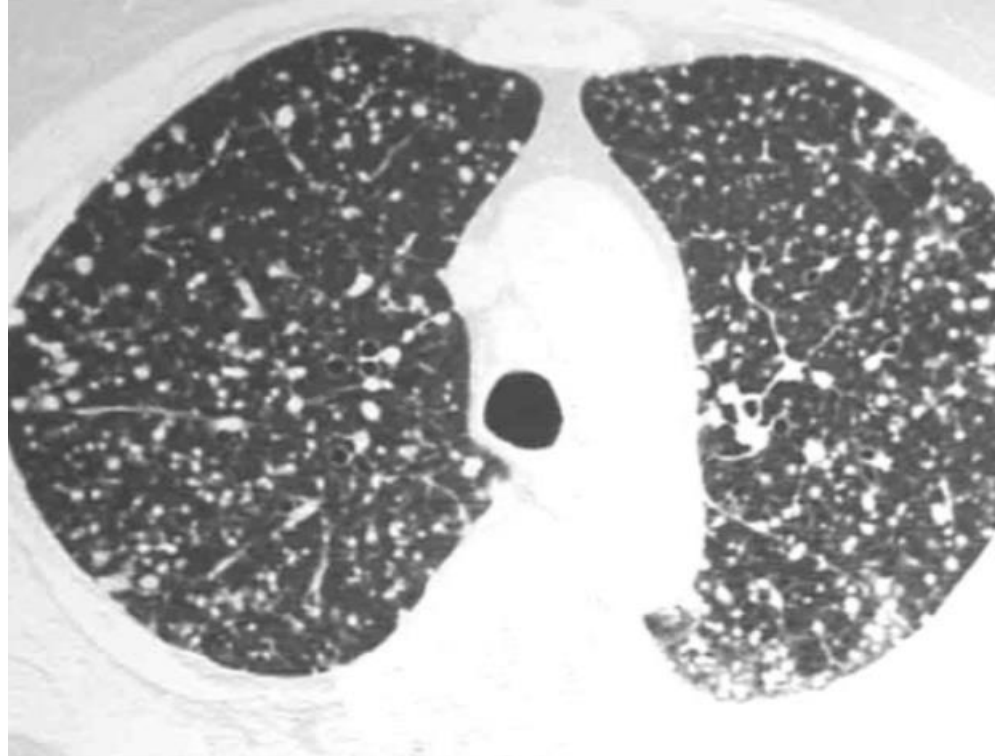
Fibrosis pulmonar

Rx de tórax frente patrón intersticial



Diagnóstico presuntivo:
Granuloma secuelar

Se ve una imagen nodular, de etiología secuelar, con calcificación difusa. En Tc, se recomienda visualizar la calcificación en ventada mediastino o ventana ósea



Diagnóstico presuntivo:

Tuberculosis miliar

Patrón intersticial micronodular



Diagnóstico presuntivo:

Patología pulmonar intersticial RETICULAR

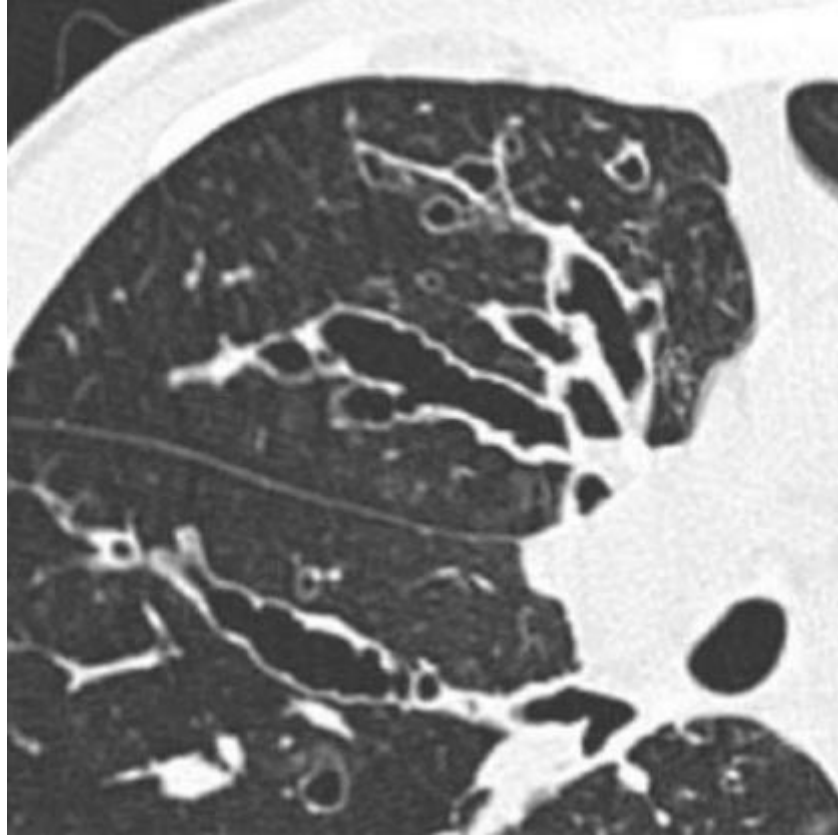
Rx de tórax frente y perfil, hallazgos compatibles con
patología intersticial reticular



Diagnóstico presuntivo:

Linfangioleiomiomatosis

TC de ventana pulmonar



Diagnóstico presuntivo:

Bronquiectasias

TC de ventana pulmonar

Recordar: Las bronquiectasias son dilataciones patológicas irreversibles de vía aérea periférica.



Diagnóstico presuntivo:

Atelectasia

En lóbulo medio derecho entre las cisuras.

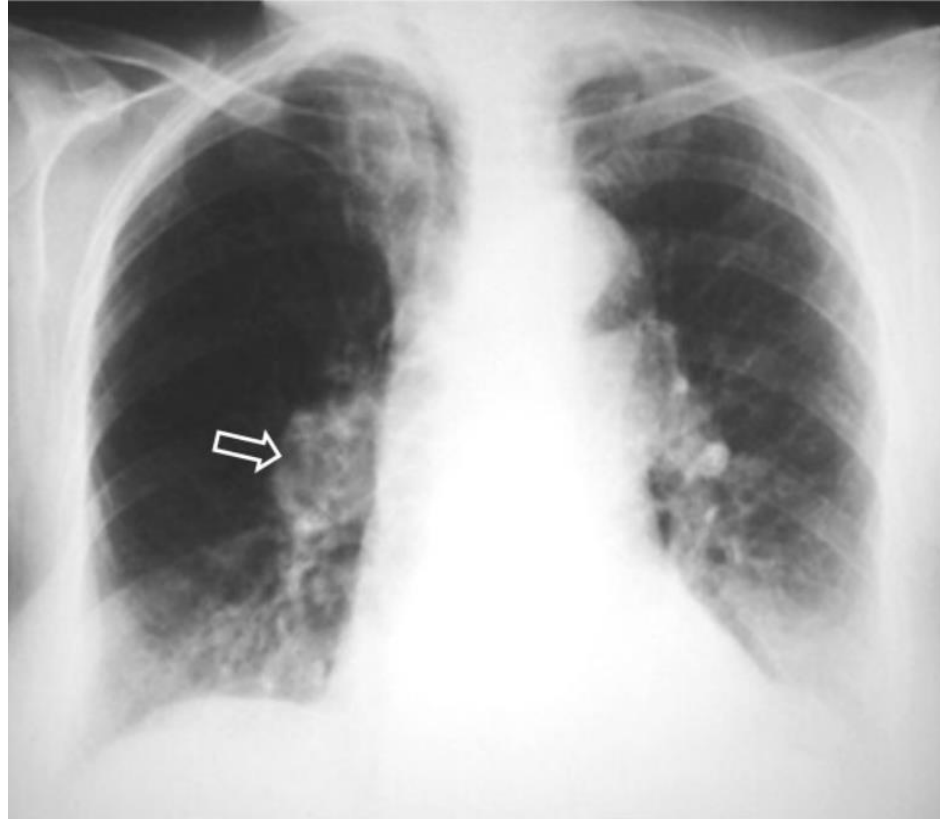
OBS: Una atelectasia pequeña de lóbulo medio ni siempre tiene tracción suficiente para desviar la tráquea.



Diagnóstico presuntivo:

TEP

Signo de Fleischner, indicativo para TEP.



Nombre el signo:

Signo de Westermark

Rx de tórax, presenta una menor visualización del parénquima pulmonar, indicativo de una oligoemia focal

El signo de Westermark, es una asociación de opacidad del parénquima causada por oligohemia y agrandamiento hiliar, provocado por el alojamiento del émbolo en la arteria pulmonar. Podemos observarlo en pacientes con TEP sin infarto.



Diagnóstico presuntivo:

Neumotórax

Rx tórax frente. Neumotorax a tensión, corrimiento del mediastino contra lateral a la lesión



Diagnóstico presuntivo:

Empiema pleural (derrame pleural)

No es posible confirmar un empiema sin toracocentesis, pero es indicativo. Se observa una radiopacidad en la base del pulmón derecho

Diagnóstico presuntivo:
Hemartoma pulmonar

TC ventana mediastínica, se observa imagen nodular ubicada
en la base izquierda que presenta áreas grasas en su interior.

